

2026年9月9日

臨床腫瘍学セミナー 緩和ケア

名古屋市立大学医学部附属西部医療センター
緩和ケアセンター
鈴木奈々

内容

- 緩和ケアとは
 - 定義と現状
 - 緩和ケアのゴール達成のために
- がんの疫学や経過
- 症状緩和
 - 痛み
- 意思決定支援
 - ACP

あなたの思う緩和ケアとはどんなもの？

- 対象はがん患者さんだけ？
- 緩和ケアは具体的に何をするの？
 - 痛みをとるだけ？
 - がん患者さんの話を聞けばいいの？
- 緩和ケアはいつから行うの？ 抗がん剤が終わった時点？ 行うのは終末期だけ？
- 緩和ケアをするのは緩和ケア医だけ？

思い浮かべてみてください

緩和ケアの定義（2002年WHO）

緩和ケアとは、生命を脅かす病に関連する問題に直面している患者とその家族に対して、痛みやその他の身体的・心理社会的・スピリチュアルな問題を早期に見出し、的確に評価を行い対応することで、苦痛を予防し和らげることを通してQOLを向上させるアプローチである。

生活の質、生命の質



緩和ケアの分類

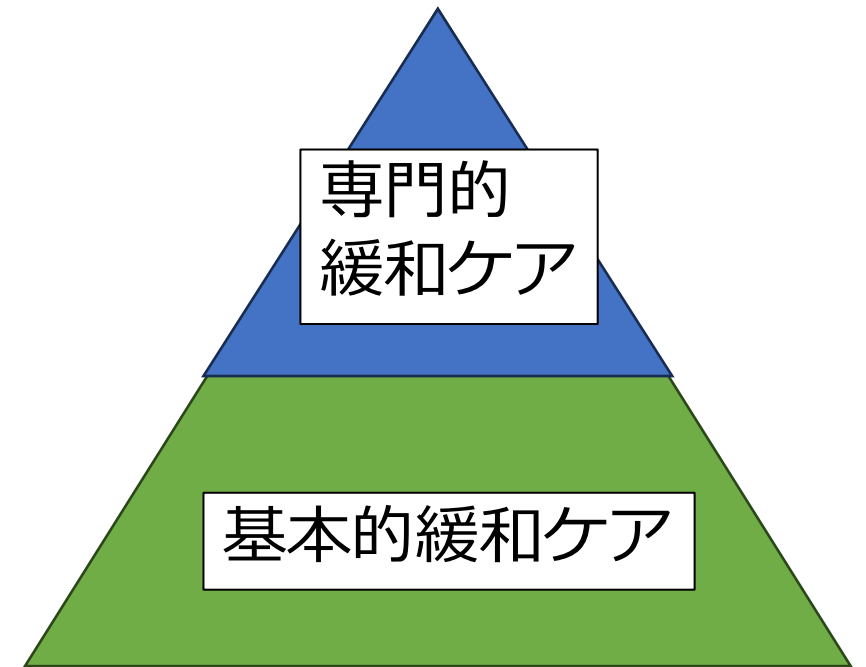
- 基本的緩和ケア：

全ての医療従事者が提供する（生命を脅かす病を抱える患者の診療に従事する一般医師、看護師、薬剤師など）

近年では、がんだけでなく
心不全、神経・筋疾患などにも
緩和ケアは必須とされている

- 専門的緩和ケア：

緩和ケアに専門に従事する医療従事者が提供する（緩和ケアチーム、緩和ケア病棟、専門在宅ケアサービス）



緩和ケアとは？

- 対象はがん患者さんだけ？
- 緩和ケアは具体的に何をするの？
痛みをとるだけ？
がん患者さんの話を聞くの？
- 緩和ケアはいつから行うの？ 抗がん剤が終わった時点？
行うのは終末期だけ？
- 緩和ケアをするのは緩和ケア医だけ？

がんでなくても生命を脅かす病
の患者さん、そのご家族が対象

痛みだけでなく様々な苦痛に対応

診断早期から行う

全ての医療者が行う

51歳男性 肺がん骨転移(stageⅣ)

X-1年6月 会社の検診でレントゲン異常を指摘されていたが、忙しく放置していた。X年5月より腰痛あり、妻より病院に行くよう度々言われていた。X年8月には通勤中に動けなくなり、救急搬送。精査の結果、肺がんの多発骨転移と診断された。

「年内のプロジェクトが終われば仕事を辞めるからそこまで治療を待ってほしい」と言われたが、「理由は理解できるが、早めの治療開始が望ましい。仕事はすぐに辞める必要はなく、治療が落ち着くまで休職をしてまず治療を優先してはどうか」と繰り返し説明し理解されたため、9月より入院で抗がん剤を開始した。お見舞いに来た妻は「もっと早く病院に行かせればよかった」と病室で号泣されており、その後別室で看護師が妻の話を聞いた。腰痛に対しては鎮痛剤を処方し、整形外科紹介してコルセットを作成した。

外来通院にて治療継続となったが、「職場にはもう居場所がないかもしれない。家族にも迷惑をかけている」と繰り返し話され傾聴した。

どれが緩和ケア？

X-1年6月 会社の検診でレントゲン異常を指摘されていたが、忙しく放置していた。X年5月より腰痛あり、妻より病院に行くよう度々言われていた。X年8月には通勤中に動けなくなり、救急搬送。精査の結果、肺がんの多発骨転移と診断された。

仕事を辞めないよう声掛け：
社会的な問題への支援

意思決定支援

「辞めれば仕事を辞めるからそこまで治療を待たないでほしい」と言われたが、「理由は理解できるが、早めの治療開始が望ましい。仕事はすぐに辞める必要はなく、治療が落ち着くまで休職をしてまず治療を優先してはどうか」と納得し、理解されたため、9月より入

家族ケア

痛みへの鎮痛剤、それ以外に
できることを検討

がん剤を開始し「もっと早く病院に行かればよかった」と病室で泣いており、その後別室で看護師が妻の話を聞いた。腰痛に対しては鎮痛剤を処方し、整形外科紹介してコルセットを作成した。

外来通院にて治療継続となったが、「職場にはもう居場所がないかもしれない。家族にも迷惑をかけている」と繰り返し話され傾聴した。

不安や今後の心配への対応

なぜ緩和ケアが広がったのか

- 伝統的な医療のゴールは病気治癒、延命だった
 - 高齢化・医学の進歩により、治らない病気でも長期的に生きられるようになった
 - 病気とどう付き合うかが注目されるようになった
 - 患者中心の医療が求められるようになった
 - 医師主導から患者の意向中心へ
 - つらい治療をせずに残された時間を過ごしたい人もいる
- いかに長生きするかだけでなく、いかにQOL高く生きるかという
緩和ケアの視点も大事だと認識されるようになった

第4期がん対策推進基本計画（概要）

第1. 全体目標と分野別目標 / 第2. 分野別施策と個別目標

全体目標：「誰一人取り残さないがん対策を推進し、全ての国民とがんの克服を目指す。」

「がん予防」分野の分野別目標

がんを知り、がんを予防すること、がん検診による早期発見・早期治療を促すことで、がん罹患率・がん死亡率の減少を目指す

1. がん予防

- (1) がんの1次予防
 - ①生活習慣について
 - ②感染症対策について
- (2) がんの2次予防（がん検診）
 - ①受診率向上対策について
 - ②がん検診の精度管理等について
 - ③科学的根拠に基づくがん検診の実施について

「がん医療」分野の分野別目標

適切な医療を受けられる体制を充実させることで、がん生存率の向上・がん死亡率の減少・全てのがん患者及びその家族等の療養生活の質の向上を目指す

2. がん医療

- (1) がん医療提供体制等
 - ①医療提供体制の均てん化・集約化について
 - ②がんゲノム医療について
 - ③手術療法・放射線療法・薬物療法について
 - ④チーム医療の推進について
 - ⑤がんのリハビリテーションについて
 - ⑥支持療法の推進について
 - ⑦がんと診断された時からの緩和ケアの推進について
 - ⑧妊孕性温存療法について
- (2) 希少がん及び難治性がん対策
- (3) 小児がん及びAYA世代のがん対策
- (4) 高齢者のがん対策
- (5) 新規医薬品、医療機器及び医療技術の速やかな医療実装

「がんとの共生」分野の分野別目標

がんになっても安心して生活し、尊厳を持って生きることのできる地域共生社会を実現することで、全てのがん患者及びその家族等の療養生活の質の向上を目指す

3. がんとの共生

- (1) 相談支援及び情報提供
 - ①相談支援について
 - ②情報提供について
- (2) 社会連携に基づく緩和ケア等のがん対策・患者支援
- (3) がん患者等の社会的な問題への対策（サバイバーシップ支援）
 - ①就労支援について
 - ②アピアランスケアについて
 - ③がん診断後の自殺対策について
 - ④その他の社会的な問題について
- (4) ライフステージに応じた療養環境への支援
 - ①小児・AYA世代について
 - ②高齢者について

4. これらを支える基盤

- (1) 全ゲノム解析等の新たな技術を含む更なるがん研究の推進
- (2) 人材育成の強化
- (3) がん教育及びがんに関する知識の普及啓発
- (4) がん登録の利活用の推進
- (5) 患者・市民参画の推進
- (6) デジタル化の推進

第3. がん対策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

- 1. 関係者等の連携協力の更なる強化
- 2. 感染症発生・まん延時や災害時等を見据えた対策
- 3. 都道府県による計画の策定
- 4. 国民の努力
- 5. 必要な財政措置の実施と予算の効率化・重点化
- 6. 目標の達成状況の把握
- 7. 基本計画の見直し

第3期がん対策推進基本計画（概要）

第1 全体目標

「がん患者を含めた国民が、がんを知り、がんの克服を目指す。」

①科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実 ②患者本位のがん医療の実現 ③尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築

第2 分野別施策

1. がん予防

- (1)がんの1次予防
- (2)がんの早期発見、がん検診
(2次予防)

2. がん医療の充実

- (1)がんゲノム医療
- (2)がんの手術療法、放射線療法、薬物療法、免疫療法
- (3)チーム医療
- (4)がんのリハビリテーション
- (5)支持療法
- (6)希少がん、難治性がん
(それぞれのがんの特性に応じた対策)
- (7)小児がん、AYA(※)世代のがん、高齢者のがん
(※)Adolescent and Young Adult: 思春期と若年成人
- (8)病理診断
- (9)がん登録
- (10)医薬品・医療機器の早期開発・承認等に向けた取組

3. がんとの共生

- (1)がんと診断された時からの緩和ケア
- (2)相談支援、情報提供
- (3)社会連携に基づくがん対策・がん患者支援
- (4)がん患者等の就労を含めた社会的な問題
- (5)ライフステージに応じたがん対策

4. これらを支える基盤の整備

- (1)がん研究
- (2)人材育成
- (3)がん教育、普及啓発

第3 がん対策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

- 1. 関係者等の連携協力の更なる強化
- 2. 都道府県による計画の策定
- 3. がん患者を含めた国民の努力
- 4. 患者団体等との協力
- 5. 必要な財政措置の実施と予算の効率化・重点化
- 6. 目標の達成状況の把握
- 7. 基本計画の見直し

第4期がん対策推進基本計画（概要）

第1. 全体目標と分野別目標 / 第2. 分野別施策と個別目標

全体目標：「誰一人取り残さないがん対策を推進し、全ての国民とがんの克服を目指す。」

「がん予防」分野の分野別目標

がんを知り、がんを予防すること、がん検診による早期発見・早期治療を促すことで、がん罹患率・がん死亡率の減少を目指す

1. がん予防

- (1) がんの1次予防
 - ①生活習慣について
 - ②感染症対策について
- (2) がんの2次予防（がん検診）
 - ①受診率向上対策について
 - ②がん検診の精度管理等について
 - ③科学的根拠に基づくがん検診の実施について

「がん医療」分野の分野別目標

適切な医療を受けられる体制を充実させることで、がん生存率の向上・がん死亡率の減少・全てのがん患者及びその家族等の療養生活の質の向上を目指す

2. がん医療

- (1) がん医療提供体制等
 - ①医療提供体制の均てん化・集約化について
 - ②がんゲノム医療について
 - ③手術療法・放射線療法・薬物療法について
 - ④チーム医療の推進について
 - ⑤がんのリハビリテーションについて
 - ⑥支持療法の推進について
 - ⑦がんと診断された時からの緩和ケアの推進について
 - ⑧妊孕性温存療法について
- (2) 希少がん及び難治性がん対策
- (3) 小児がん及びAYA世代のがん対策

「がんとの共生」分野の分野別目標

がんになっても安心して生活し、尊厳を持って生きることのできる地域共生社会を実現することで、全てのがん患者及びその家族等の療養生活の質の向上を目指す

3. がんとの共生

- (1) 相談支援及び情報提供
 - ①相談支援について
 - ②情報提供について
- (2) 社会連携に基づく緩和ケア等のがん対策・患者支援
- (3) がん患者等の社会的な問題への対策（サバイバーシップ支援）
 - ①就労支援について
 - ②アピアランスケアについて
 - ③がん診断後の自殺対策について
 - ④その他の社会的な問題について
- (4) ライフステージに応じた療養環境への支援
 - ①小児・AYA世代について
 - ②高齢者について

- (4) がん登録の利活用の推進
- (5) 患者・市民参画の推進
- (6) デジタル化の推進

「緩和ケア」について、すべての医療従事者が診断時から治療と併せて取り組むべきとの趣旨から、がん医療分野の中に記載

するために必要な事項

5. 必要な財政措置の実施と予算の効率化・重点化
6. 目標の達成状況の把握
7. 基本計画の見直し

緩和ケアの現状

進行がんに対する早期からの緩和ケアによる、患者のQOL向上、抑うつ低下、生存期間の延長が報告された論文が発表されているものの…

Temel JS. NEJM 2010

- 日本では、必要な患者に適切な緩和ケアが提供できていない
がん拠点病院で最期を迎えた患者の遺族調査で、患者がからだの苦痛なく過ごせたと考えているのは50.0%
- 病院での死亡率がいまだに高い
病院診療所が72.4%、緩和ケア病棟12.5%、自宅11.0%

緩和ケアの阻害因子

- 主治医チームの問題

- 関心、知識、技能の不足(48%)

- 患者とのコミュニケーション不足(21%)

緩和ケアは終末期のみ、緩和ケアは緩和
ケアチームが行うものという誤解
患者と話す時間がない

- 緩和ケア専門家の問題

- 専門家の不足(14%)

- 緩和ケア病棟の不足、アクセス困難(12%)

緩和ケア指導医
全国で約360名しかいない

- 社会的な問題

- 一般市民における緩和ケアの知識不足(29%)

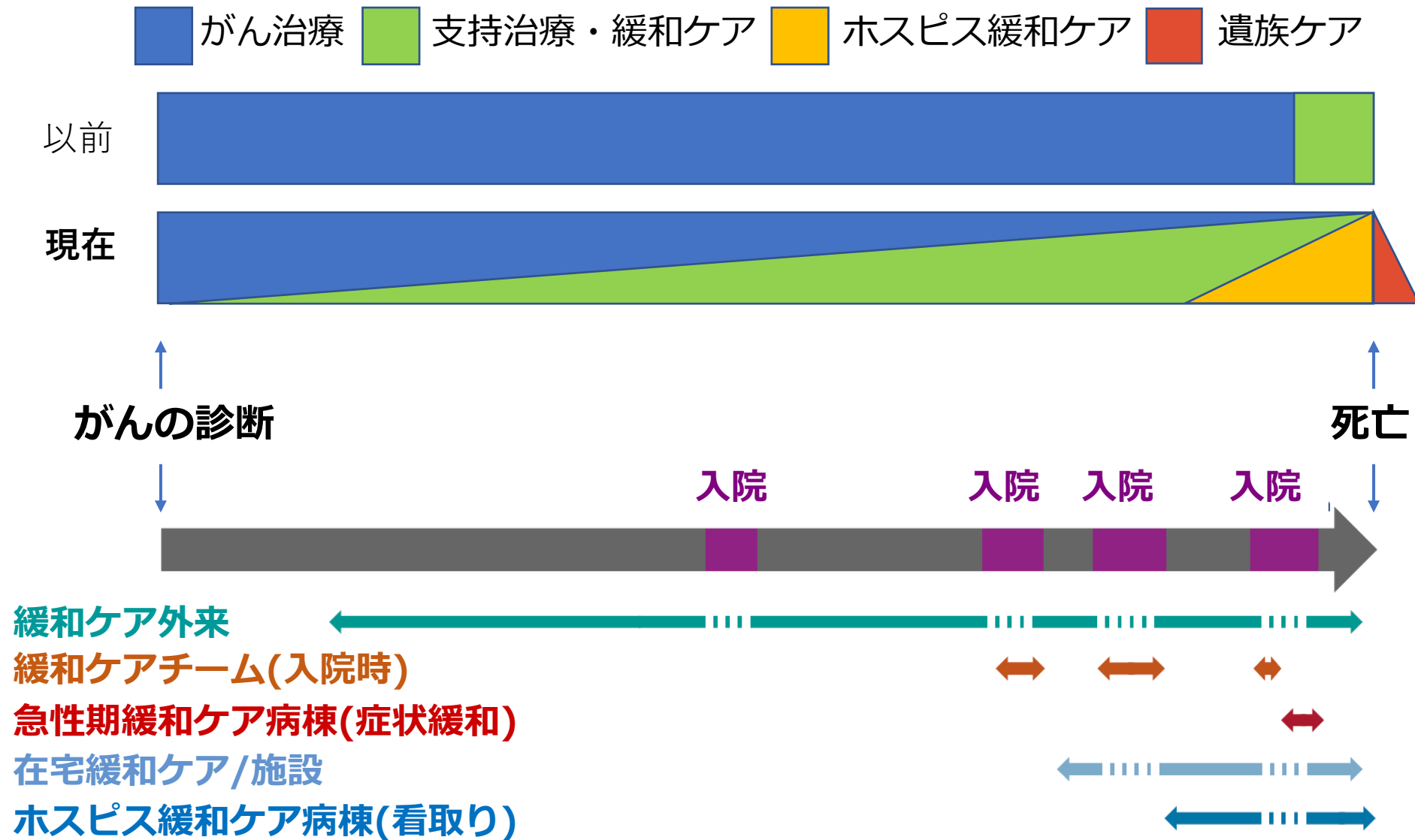
緩和ケアを受ける = 死に近い
という誤解

- 教育の問題

- 大学院レベルの教育不足(16%)

名市大では緩和ケアの授業はこの1コマだけ
研修医になってからも学ぶ機会が少ない

専門的緩和ケアとの連携



Hui D, et al. J Clin Oncol 2020, Annals Palliat Care 2015 を日本の医療事情にあわせて改変

緩和ケアのゴールは

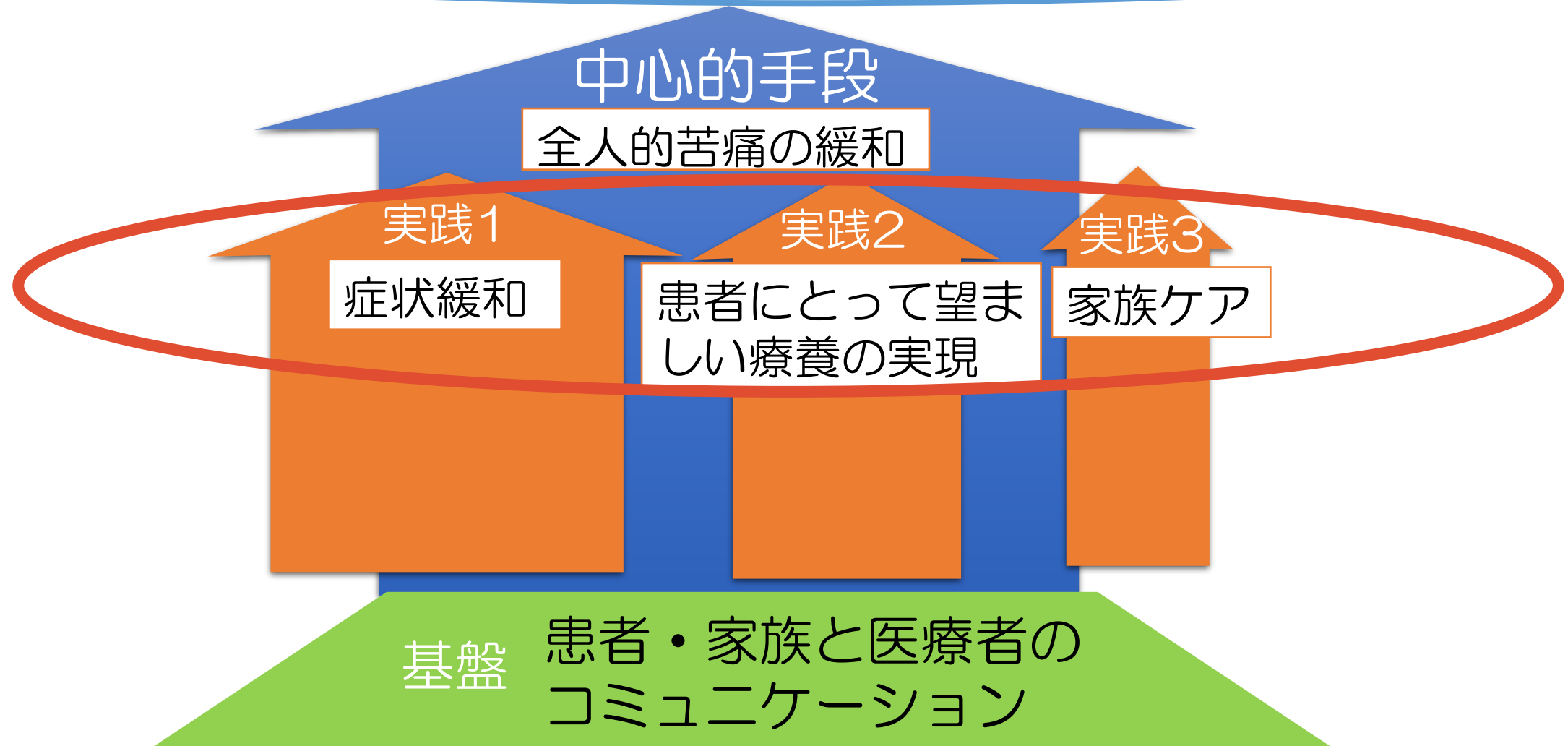
- 先ほども述べたように、がん医療のゴールには、
完治・生存期間の延長・QOLの向上などがある
→医療者側も患者側も完治や生存期間の延長に注目しやすい
- 緩和ケアとは、QOLを向上させるアプローチ

生命を脅かす疾患があったとしても、その疾患に焦点を当てるのではなく、疾患を抱えたひとりの人が、その人らしく生きれるように支援することが緩和ケア

ひとりひとりの患者に合わせた、目標の達成も重要

緩和ケアのゴール達成のために

緩和ケアのゴール：患者のQOL向上(患者の目標の達成)



実践1：症状緩和

- 患者は様々な身体・精神症状を抱え、それによってQOLが低下する
- 原因疾患の治療と対症療法を組み合わせ、苦痛を和らげる
 - 痛み、呼吸困難、咳嗽喀痰、悪心嘔吐、便秘下痢、腹部膨満感、食欲低下、倦怠感、不眠、せん妄、不安など
 - 薬物療法だけでなく非薬物療法も考える

症状をゼロにすることが難しいことも多く、
患者と目標を共有することが重要

実践2：患者にとって望ましい療養の実現

- 病状進行時には、積極的治療と患者にとっての望ましい療養の両立が困難になることがある
 - 家族と一緒に過ごす時間が失われる
 - 治療のための苦痛が負担となる
- 患者が何を大切にしているのか、どのように過ごしたいのか、早いうちから確認していく

先を見据えて話し合い、治療のゴールを共有する

望ましい療養・死とは

- 一般人口及び緩和ケア病棟の遺族を対象

1. 共通性が高い、望ましい死の構成要素

身体的、心理的な
苦痛がないこと

望んだ場所で
過ごすこと

医療スタッフとの
良好な関係

希望をもって
生きること

他者の負担に
ならないこと

家族との
良好な関係

自立していること

落ち着いた環境で
過ごすこと

人として尊重
されること

人生を全うした
と感じられること

2. やや共通性が高い、望ましい死の構成概念

自然なかたちで
亡くなること

他人に感謝し、心の
準備ができること

役割を果たせる
こと

死を意識しないで
過ごすこと

3. 相対的に共通性が低い、望ましい死の構成概念

納得するまで
がん闘うこと

自尊心を保つこと

残された時間を知り、
準備をすること

信仰をもつこと

人によって望む療養は異なる。
目の前の患者さんは、何を望む？

Miyashita M, et al. Ann Oncol 2007

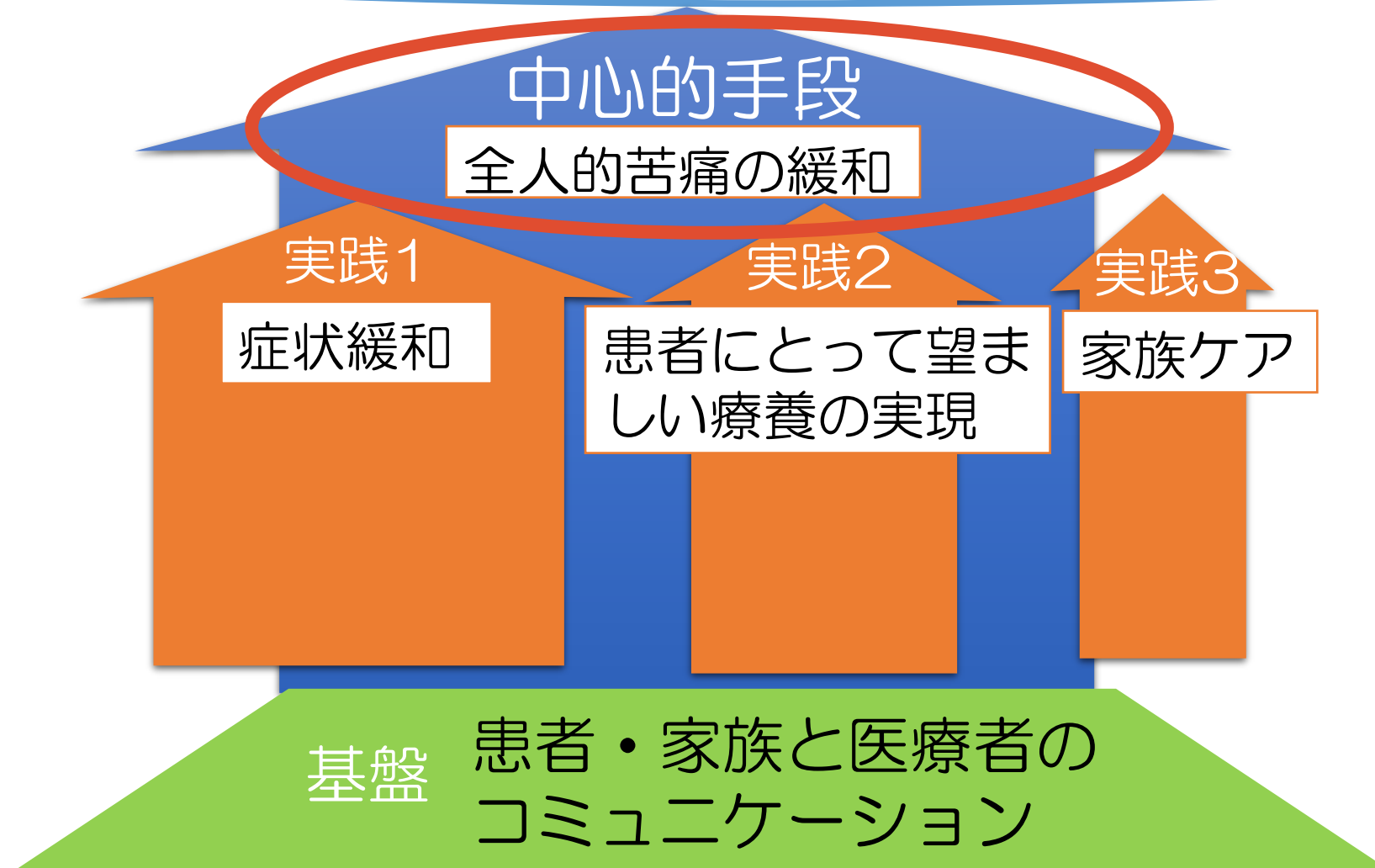
実践3：家族ケア

- 家族は患者本人の良き理解者
 - ご本人の苦痛を代弁できる
 - 他覚的にみた患者の評価
 - 意思決定の共有
- 家族も大きな苦痛を抱えることが多く、第二の患者とされる

家族をケアすることは、患者のケアに繋がる

緩和ケアのゴール達成のために

緩和ケアのゴール：患者のQOL向上(患者の目標の達成)

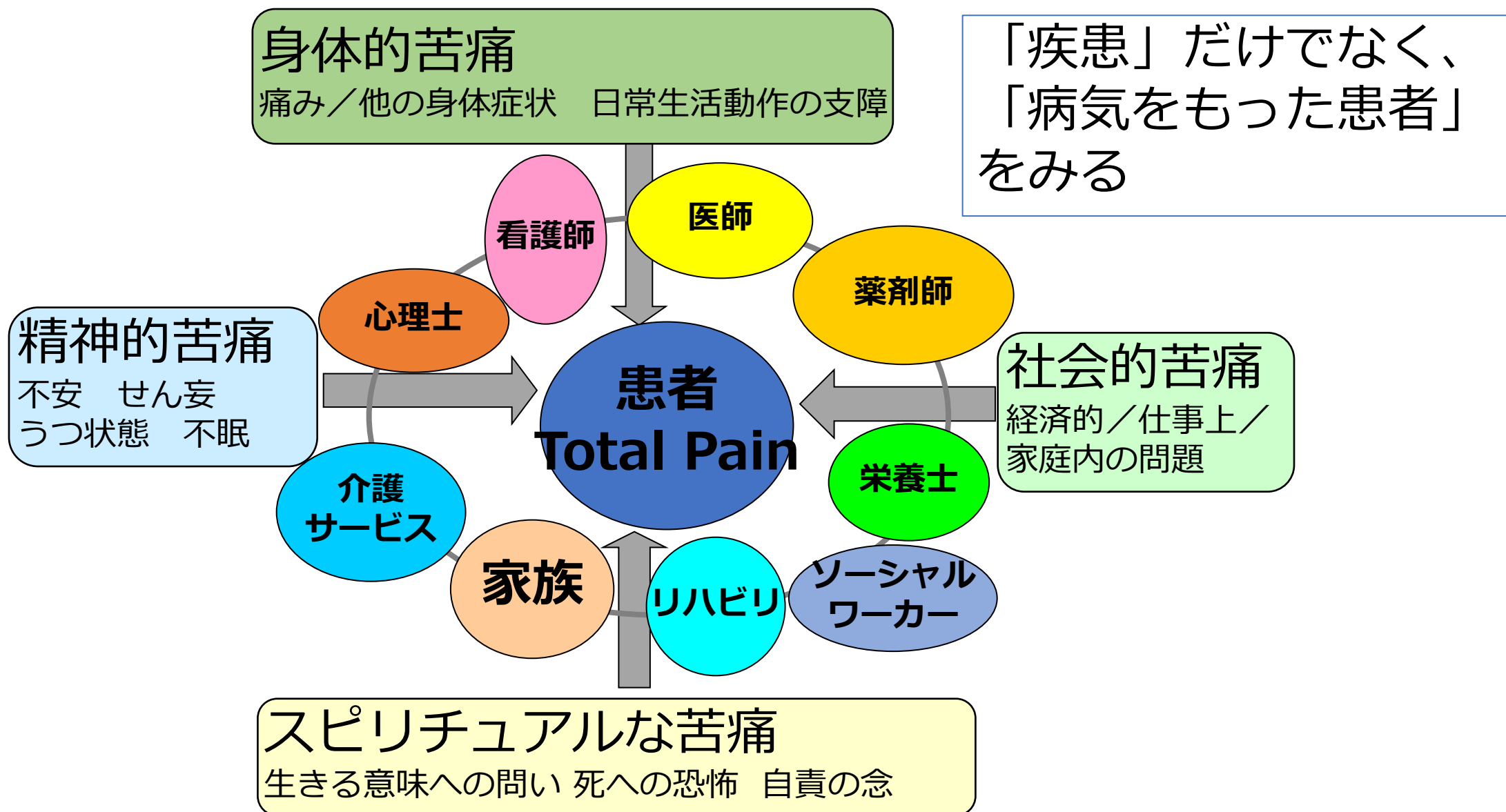


中心的手段：全人的苦痛緩和

- 身体的苦痛、精神的苦痛、社会的苦痛、スピリチュアルな苦痛に包括的に対応する
 - 単独の苦痛しかない患者の方が少ない
- 様々な職種で対応することが必要となる

患者がどのような苦痛が抱えているか
気づくことが第一歩

全人的ケアとチームアプローチ



スピリチュアルな苦痛とは

スピリチュアルペイン

自分がこうありたいと思う自分と、現実の自分自身が乖離していることによる辛さ。

- 関係性：「死んだら何も残らない、孤独だ、誰もわかってくれない」
- 自律性：「人の世話になって迷惑をかけ、何の役にも立たず、生きている価値がない」
- 時間性：「もうすぐ死ぬのだから、何をしてもしょうがない」

全人的ケアとチームアプローチの例

心理士、医師、看護師など多職種で苦痛に寄り添いながら、精神的な診断がつくのか、薬剤が必要なのかも検討

これ以上痛くなるかも…不安でおかしくなりそう

精神的苦痛

不安 せん妄
うつ状態 不眠

どうして自分がこんな目にあうのか。家族に迷惑をかけてしまう。

看護師など多職種で傾聴や寄り添いを中心としたサポート

身体的苦痛

痛み／他の身体症状 日常生活動作の支障

肺がんの骨転移で背中が痛い！

医師による鎮痛薬調整。
薬剤師による説明。
理学療法士による痛みが少ない動き方の指導

看護師

医師

薬剤師

心理士

患者
Total Pain

社会的苦痛

経済的／仕事上／
家庭内の問題

痛みのせいで働けない。
金銭的に苦しい

介護
サービス

家族

リハビリ

栄養士

ソーシャル
ワーカー

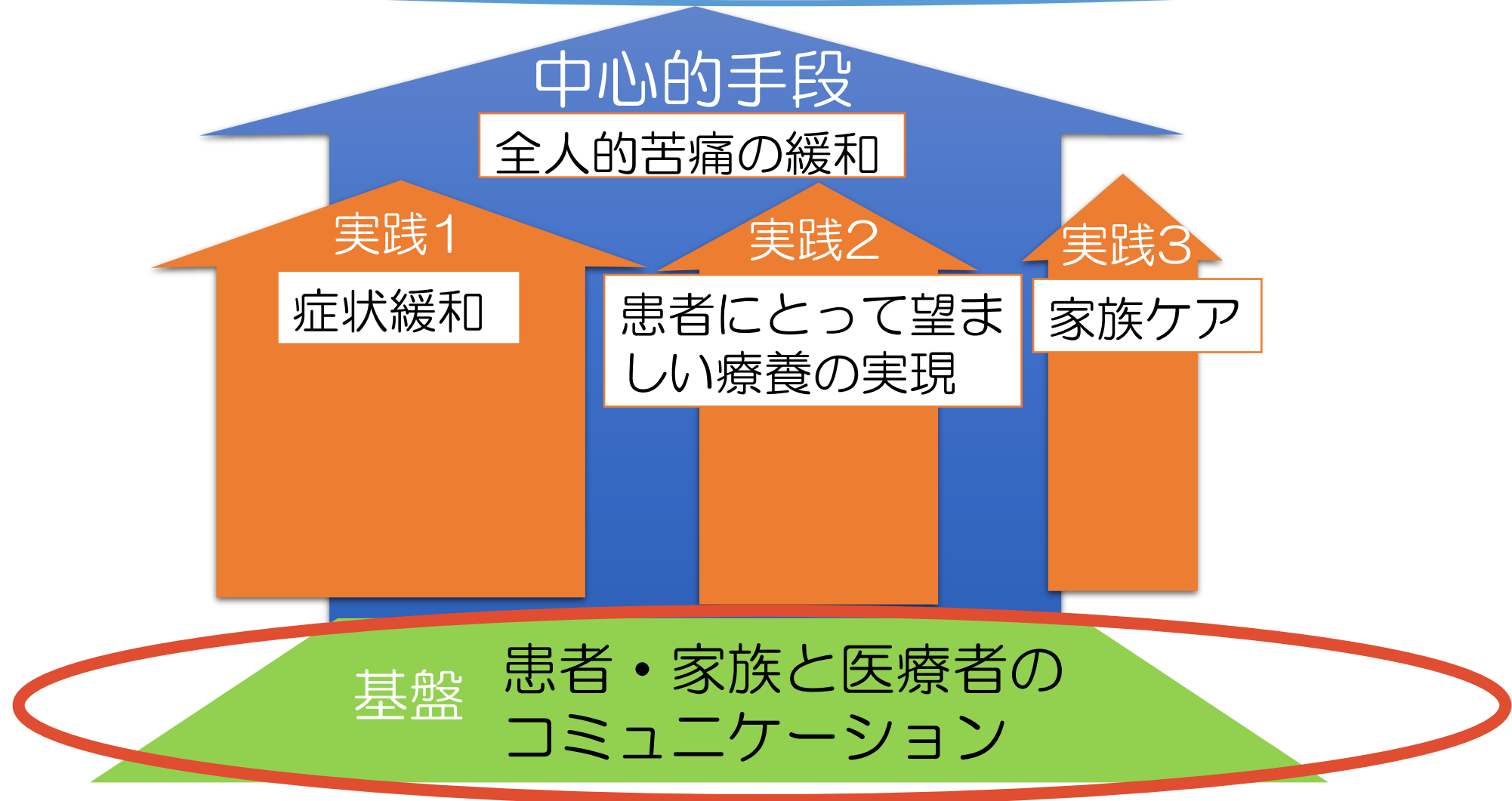
スピリチュアルな苦痛

生きる意味への問い 死への恐怖 自責の念

SWによるサポート。
介護申請など
できることを検討

緩和ケアのゴール達成のために

緩和ケアのゴール：患者のQOL向上(患者の目標の達成)



基盤：患者・家族とのコミュニケーション

- まずは患者・家族の話を聴くことから始める
 - 関係性の構築が重要
- 患者・家族の病状や予後への理解を確認していく
 - 患者・家族と医療者が同じ方向を向いて進むためにも必要
- 適切な情報提供を行う
 - どの程度の情報が欲しいのか、自分で決めたいのか

率直かつ思いやりのあるコミュニケーションを
一方的な情報伝達でなく「共有」することが必須

例：51歳男性 肺がん骨転移

緩和ケアのゴール：患者のQOL向上(患者の目標)

目標：なるべく苦痛なく、
自宅で家族と
長い間過ごし
仕事続ける

患者の心配事、
気になっている
こと、価値観の
確認

中心的手段

全人的苦痛の緩和

実践1

症状緩和

実践2

患者にとって望ま
しい療養の実現

実践3

家族ケア

在宅の環境を
整える
患者、家族の
病状や予後理
解の確認

痛みを生活
できる程度
に落ち着け
る

家族にも困り
ごとやご不安
がないかなど
声掛け

基盤

患者・家族と医療者の
コミュニケーション

緩和ケアはAIには難しい

単純な①症状緩和であれば、診断・治療選択でAIに置き換わる可能性もある（例：術後の痛みなど単一原因による薬剤選択）

しかし、複数の問題が絡んでいたり、ゴール設定が個人によって異なることから、AIだけでは難しいと考えられる

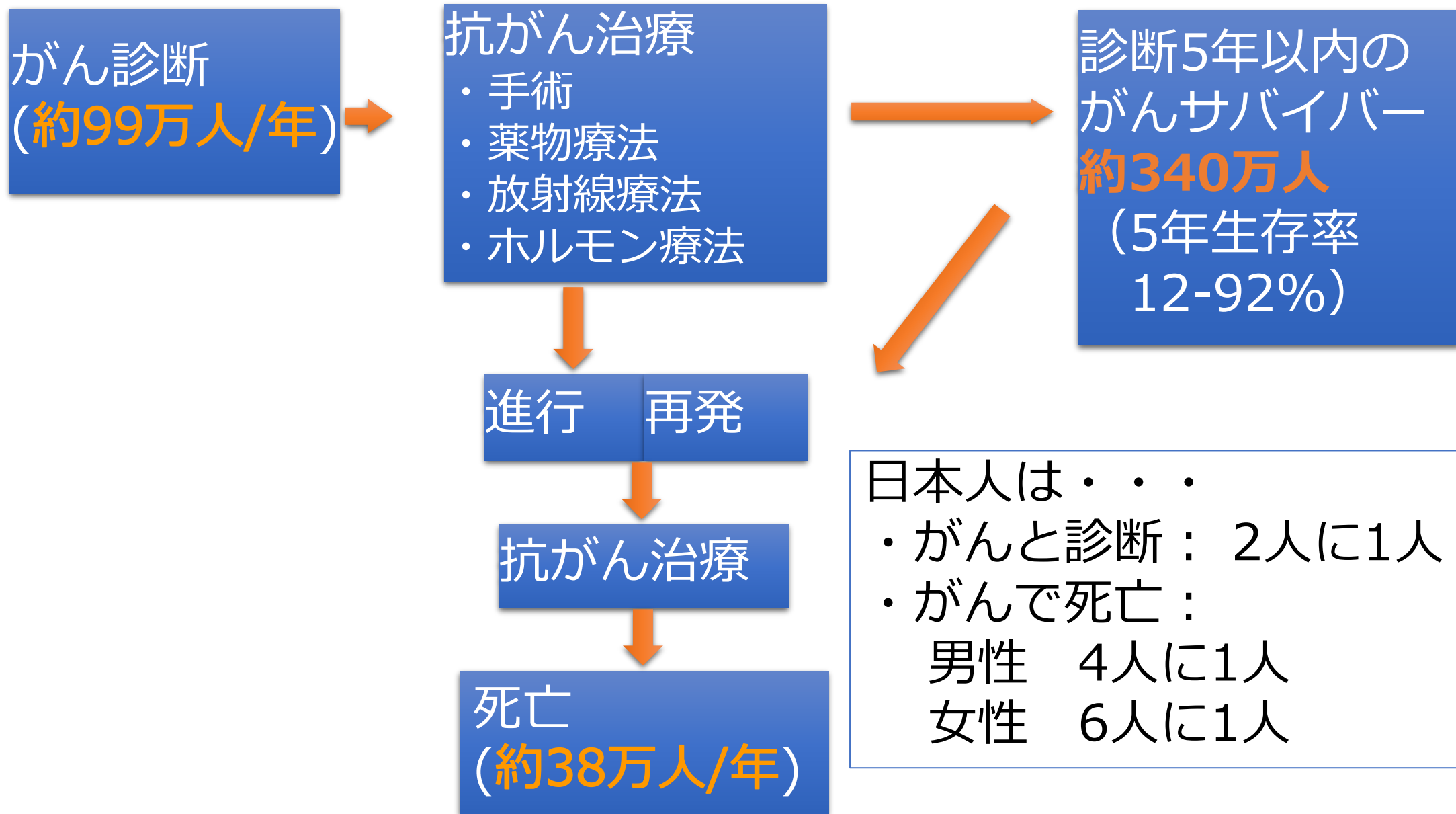
これからの時代に
必要とされる
分野だと思います



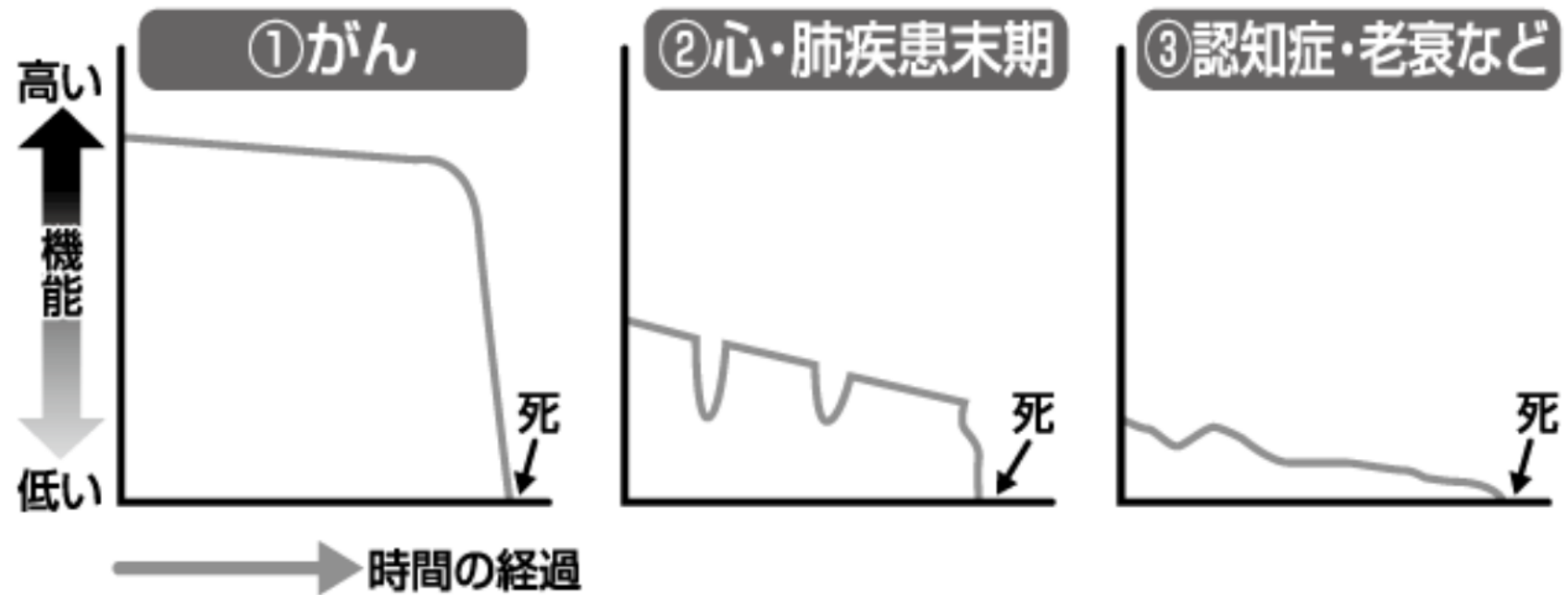
内容

- 緩和ケアとは
 - 定義と現状
 - 緩和ケアのゴール達成のために
- がんの疫学や経過
- 症状緩和
 - 痛み
- 意思決定支援
 - ACP

がんの経過と疫学



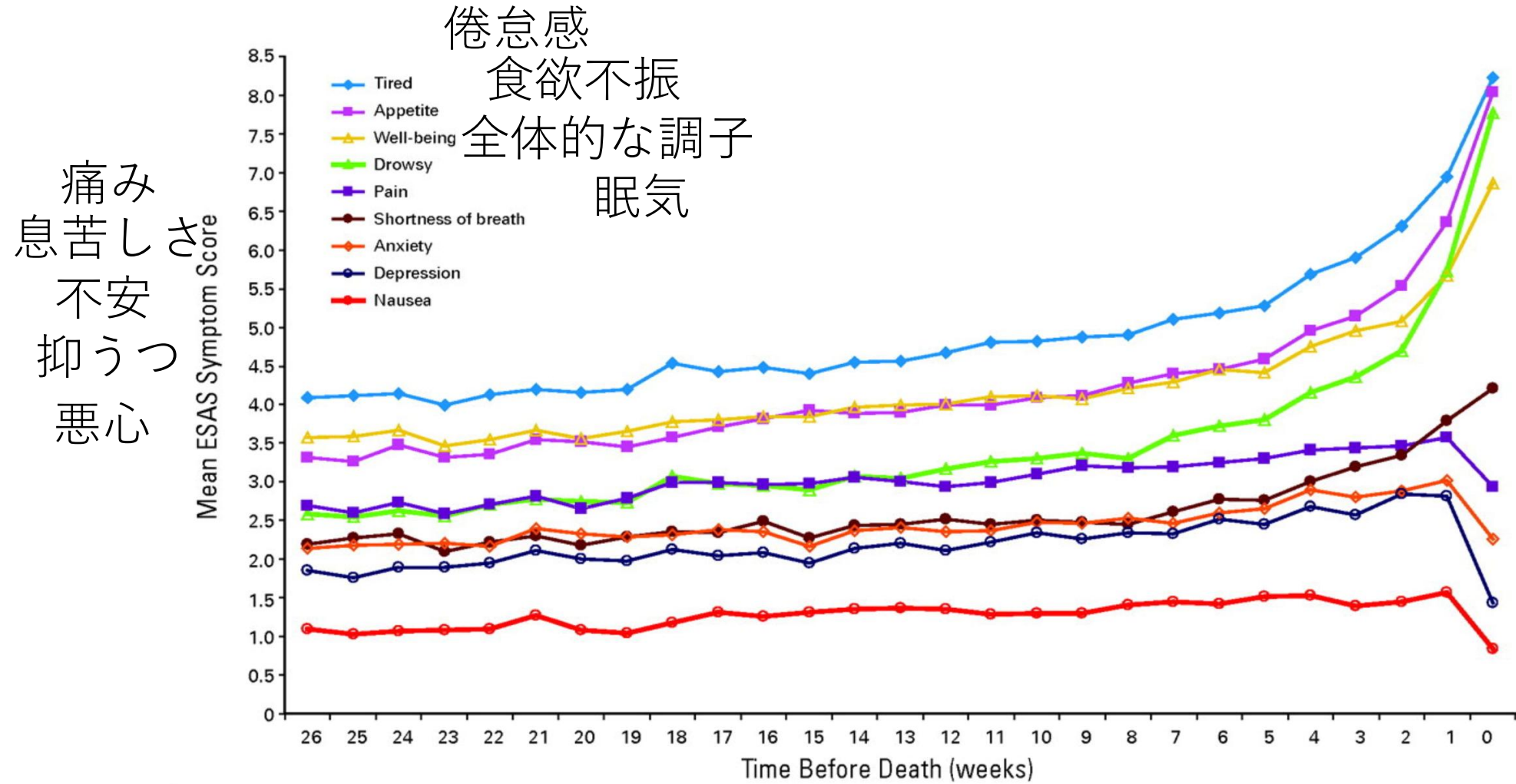
がんの経過



がんでは比較的長い間機能は保たれ、最後の数か月で急速に機能が低下する

疾患によって経過が異なる

がん患者の症状の推移



時期による代表的苦痛

- **診断初期～抗がん剤治療中**

告知による精神的負担 初発症状による身体的負担
これまでの生活ができなくなる社会的負担
治療による副作用 経済的負担

- **終末期**

がん進展に伴う症状 死に直面する精神的負担
社会的役割が果たせない負担

- **がんサバイバー**

治療の長期的副作用 二次がん
再発不安 仕事の復職

病気の軌跡を考えながら患者と関わる

- 今が軌跡のどこにいるのか
これからよくなるのか、このままなのか、悪くなるのか

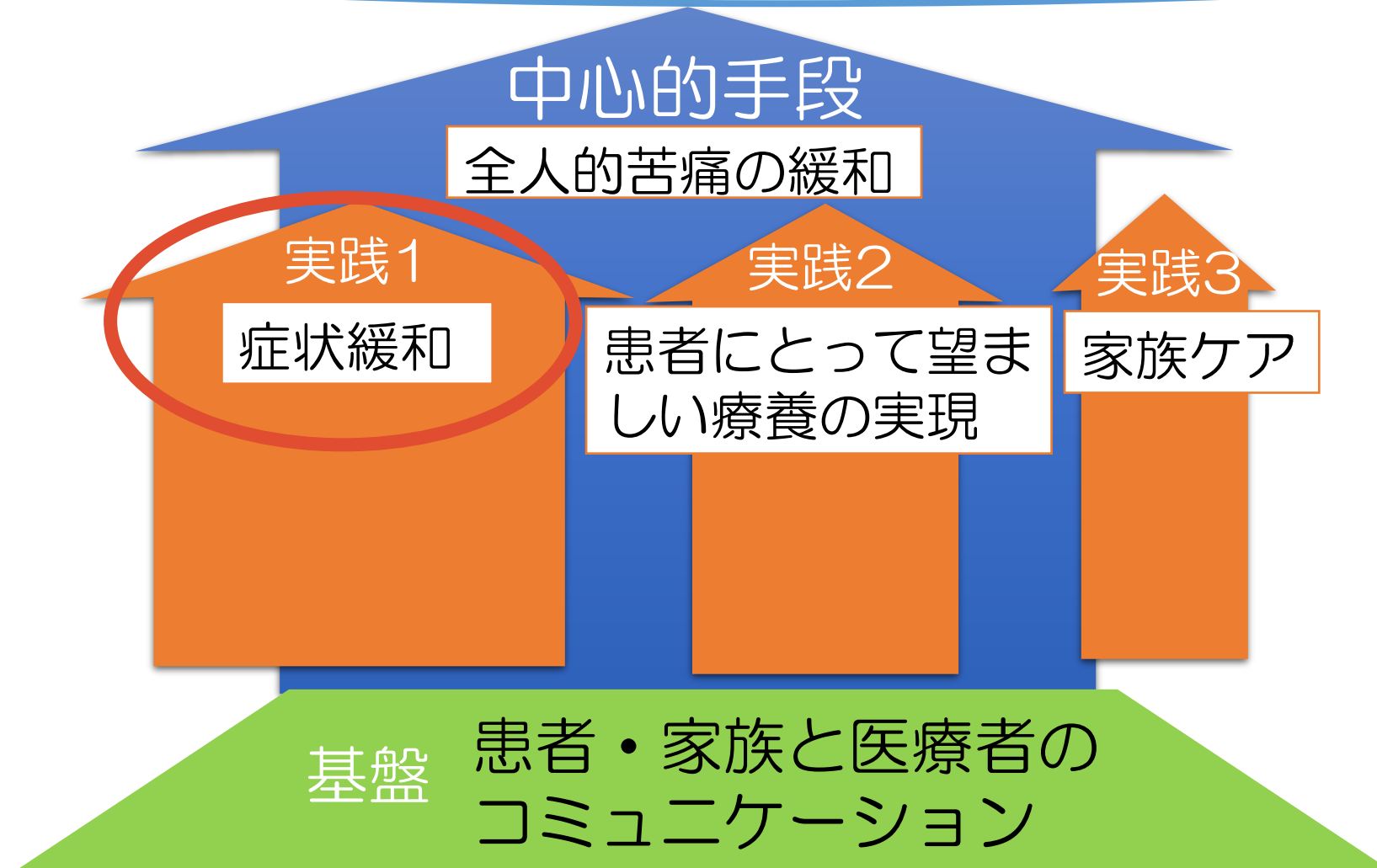
目の前の患者さんが今後どんな経過をたどるかを考えながら、
その患者さんにとっての目標(ゴール)を考える

内容

- 緩和ケアとは
 - 定義と現状
 - 緩和ケアのゴール達成のために
- がんの疫学や経過
- 症状緩和
 - 痛み
- 意思決定支援
 - ACP

緩和ケアのゴール達成のために

緩和ケアのゴール：患者のQOL向上(患者の目標の達成)



「痛み」の定義

「痛み」は、実際の組織障害、あるいは組織損傷の可能性。
または障害の際に表出される不快な感覚および情動体験で
ある。

国際疼痛学会(IASP)による

つまり、「痛み」は主観的なものであり、
第三者が客観的に評価することは困難であることの認識が必要

この講義でのスライドは、厚生労働省研究班作成「痛みの教育コンテンツ」からの引用が含まれており、内容を一部改変しております。

痛みの分類

- ・ 原因による分類：がん疼痛と非がん疼痛
- ・ 病態による分類：

侵害受容性疼痛と神経障害性疼痛と痛覚変調性疼痛

- ・ 発症や持続による分類：急性疼痛と慢性疼痛

がん患者の持っている痛み≠がん疼痛

- ・ **がん疼痛**

浸潤や転移に伴う痛み

- ・ **がんの進行に関連する疼痛**

筋委縮、体動困難、褥瘡などによる痛み

- ・ **がん治療に関連する疼痛**

術後疼痛、化療に伴う末梢神経障害

- ・ **がんと無関係の疼痛**

他の疾患(腰椎変性、帯状疱疹)や加齢性変化

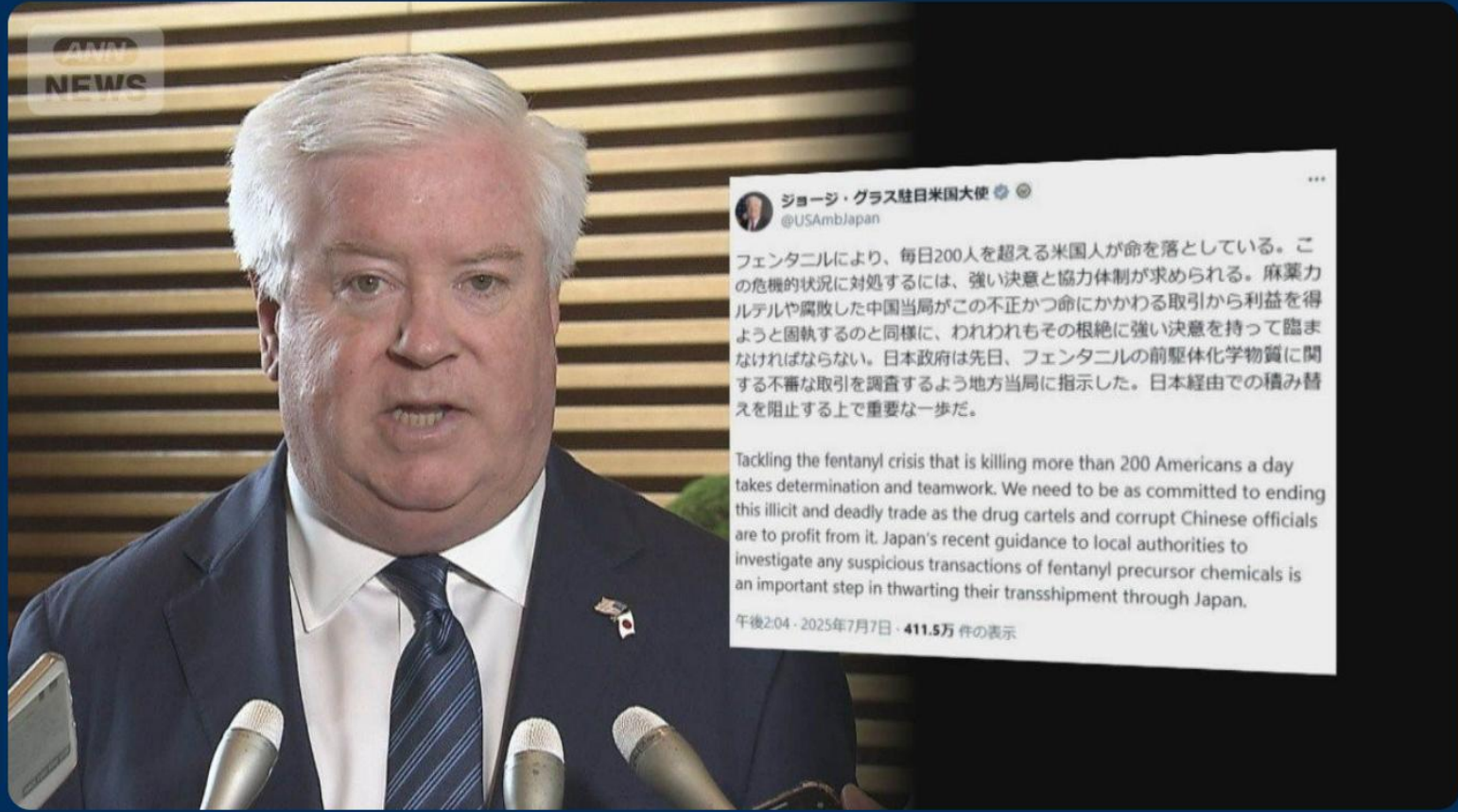
がん患者でも痛みの原因ががんでない時は、がん疼痛と同じ対応はしない！（オピオイドの積極的投与は推奨しない）

オピオイド危機

国際

2025年7月9日 12:55

「史上最悪の麻薬」フェンタニル脅威 中毒死は日本でも 世界
拡散「一粒で死に至る」



非がん性慢性疼痛への
オピオイド処方



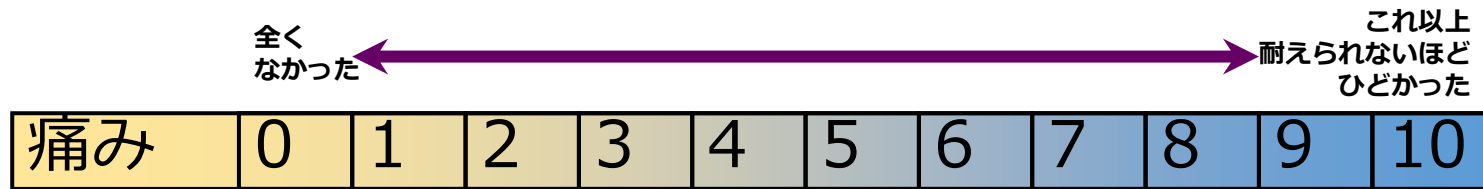
オピオイドの過量投与などで、
アメリカで1日平均
224人の死者(2022)

侵害受容性疼痛(体性痛・内臓痛)と神経障害性疼痛

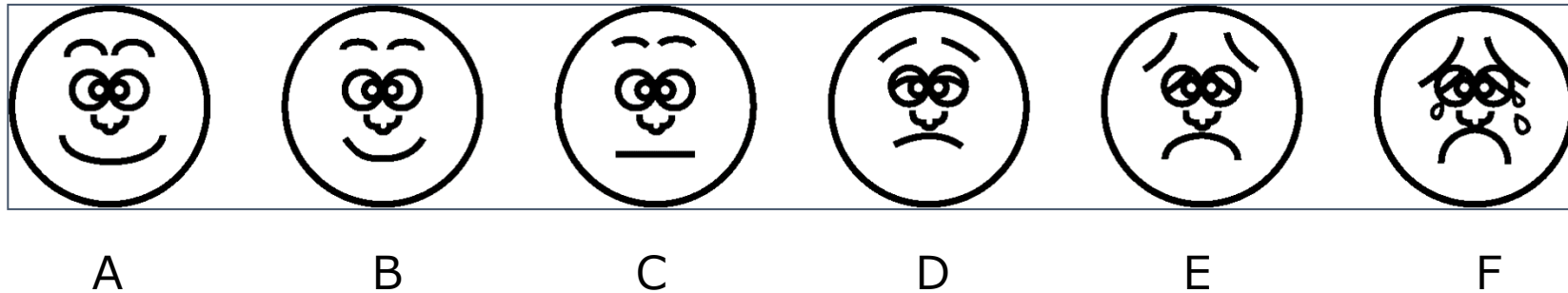
分類	侵害受容性疼痛		神経障害性疼痛
	体性痛	内臓痛	
障害部位	・ 皮膚や骨、関節、筋肉、結合組織などの体性組織	・ 管腔臓器(食道、小腸、大腸など)、被膜を有する固型臓器(肝臓、腎臓など)	・ 末梢神経、脊髄神経、視床、大脳（痛みの伝達路）
侵害刺激	・ 機械的刺激(切る、刺す、破壊するなど)	・ 管腔臓器の内圧上昇 ・ 臓器被膜の急激な伸展 ・ 局所および周囲の炎症	・ 神経の圧迫や巻き込み、断裂
痛みの特徴	・ 局在が明確 ・ 体動に伴って悪化する	・ 局在が不明瞭	・ 障害神経の支配領域 ・ 感覚異常、運動障害、自律神経系の異常（発汗異常、皮膚の色調変化など）を伴うことも
鎮痛薬の効果	・ 非オピオイド、オピオイドが有効 ・ レスキューの使い方の工夫	・ 非オピオイド、オピオイドが有効 ・ 消化管内圧の上昇には減圧、ステロイドなど考慮	・ 非オピオイド鎮痛薬、オピオイドの効果乏しい時には、鎮痛補助薬の併用を考慮する

痛みの程度を評価

- Numerical Rating Scale (NRS)
症状の程度を数値化して聞く

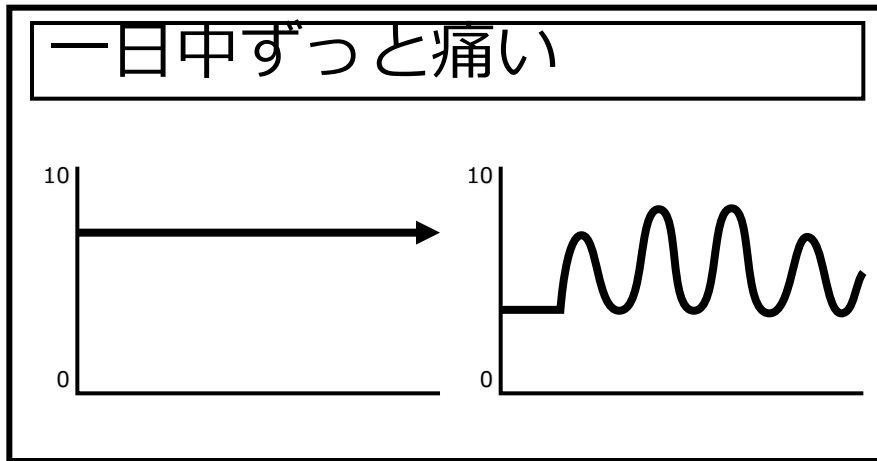


- フェイススケール: **FPS** (Face Pain Scale)
AからFの顔の表情について説明後、患者が選択する。



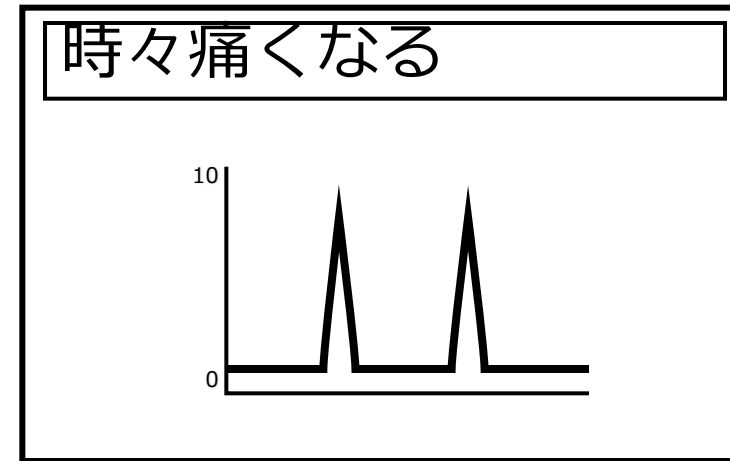
痛みのパターンを聞く

- 痛みはパターンから、
持続痛と突出痛に分けられる



持続痛

持続痛 + 突出痛



突出痛

痛みの部位確認

- 痛みの場所は、その都度確認
- 医療者はがんの痛みのことを話していたら、患者は違う部位の非がんの痛みについて話していたということはよくある

(脊椎転移の)
痛みはどうか？



(下痢で
お腹が)
痛いです。



(元々ある腰痛が)
痛くてたまらない。
薬をください。

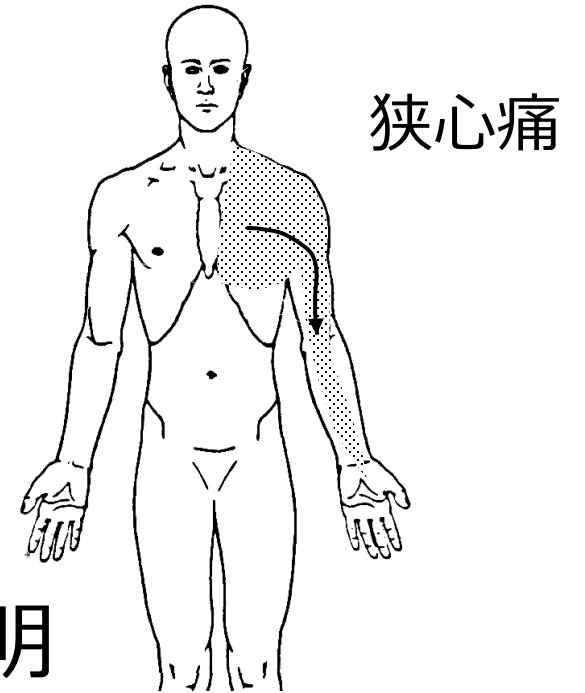
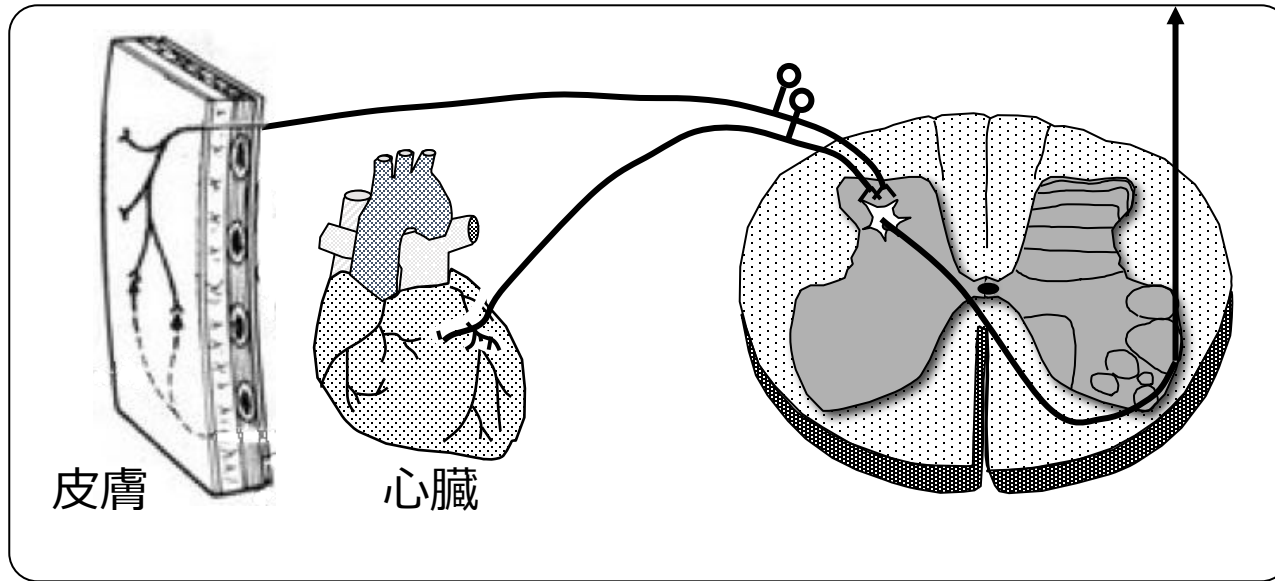


お腹の腫瘍は
よくなってる
はずなのに…



関連痛

脊髄後角の同一侵害受容ニューロンにおいて皮膚と内臓からの侵害性入力収束がみられる。



これらの収束は関連痛のメカニズムを説明する中枢説の一つだと考えられている。
例) 狭心症の時に左手が痛いことがある。

生活の支障・満足度を聞く

- 症状が生活に及ぼしている影響、今の治療についての満足度を聞く

その症状により、
生活に支障が出て、
何か対応が必要な状況
でしょうか？

その症状に対して
今の治療で
満足されていますか？



痛みの性質を評価

短縮版マギル痛み質問紙 R. Melzack® (有村達之 細井昌子 翻訳)

SF-MPQ-J-KV: Short-form McGill Questionnaire-Japanese-Kyushu University Version

A) PRI

あなたのここ一週間の平均的な痛みはどんな感じですか。
あてはまる表現の程度を示す数字を○で囲んでください。

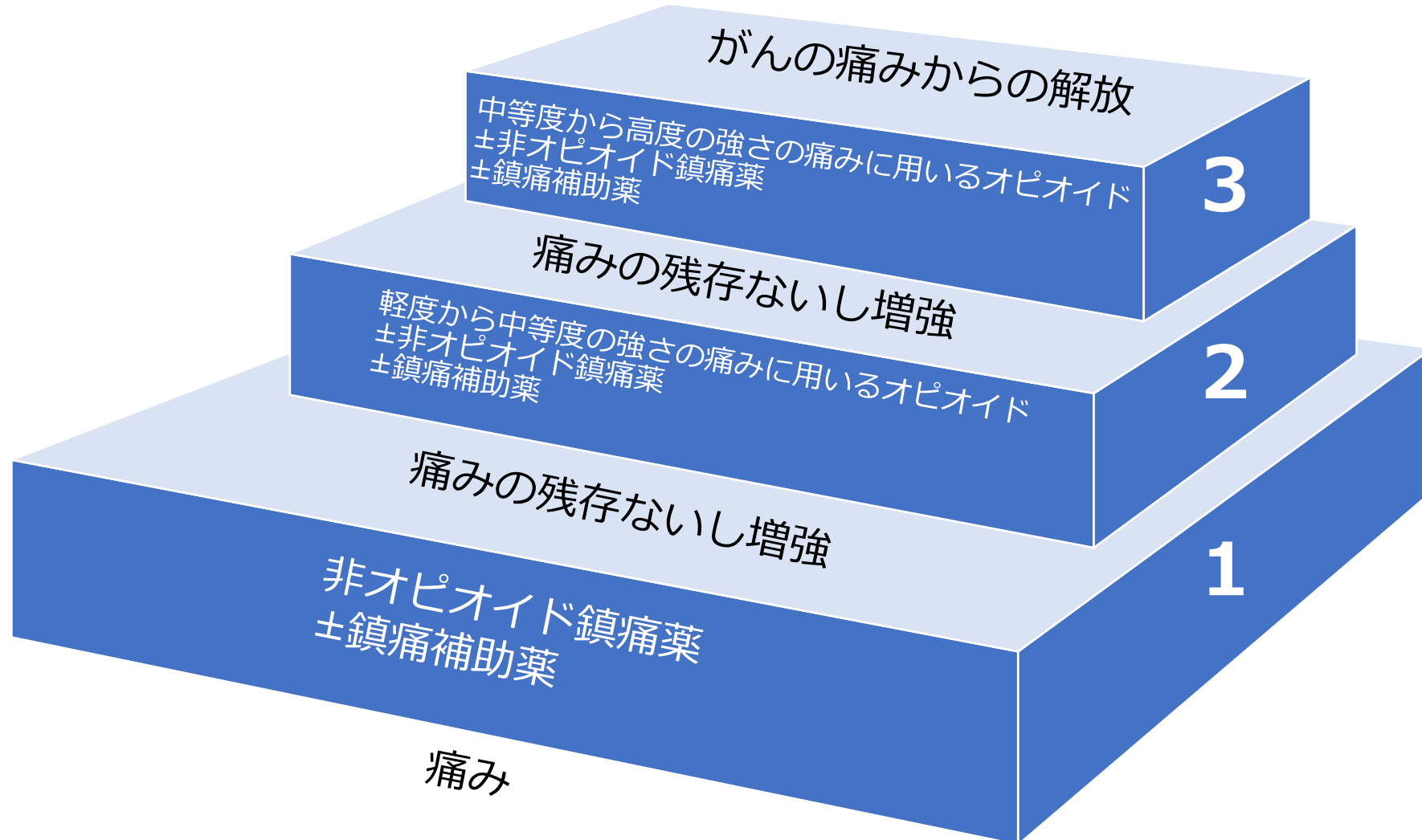
	なし	軽度	中等度	重度
1. ずきんずきんする	0	1	2	3
2. ビーンと走るような	0	1	2	3
3. 刃物でつきさされるような . . .	0	1	2	3
4. 鋭い	0	1	2	3
5. ひきつるような	0	1	2	3
6. 絶え間のない鈍い	0	1	2	3
7. 焼けるような	0	1	2	3
8. うずくような	0	1	2	3
9. 重苦しい	0	1	2	3
10. さわると痛い	0	1	2	3
11. 割れるような	0	1	2	3
12. 病気でノミイキになるような . .	0	1	2	3

痛みには感覚的な側面と情緒的な側面がある
痛みを言葉で表すことで、どのような要素の痛みなのかを評価するのは有用

鎮痛薬の使い方に関する5原則 4

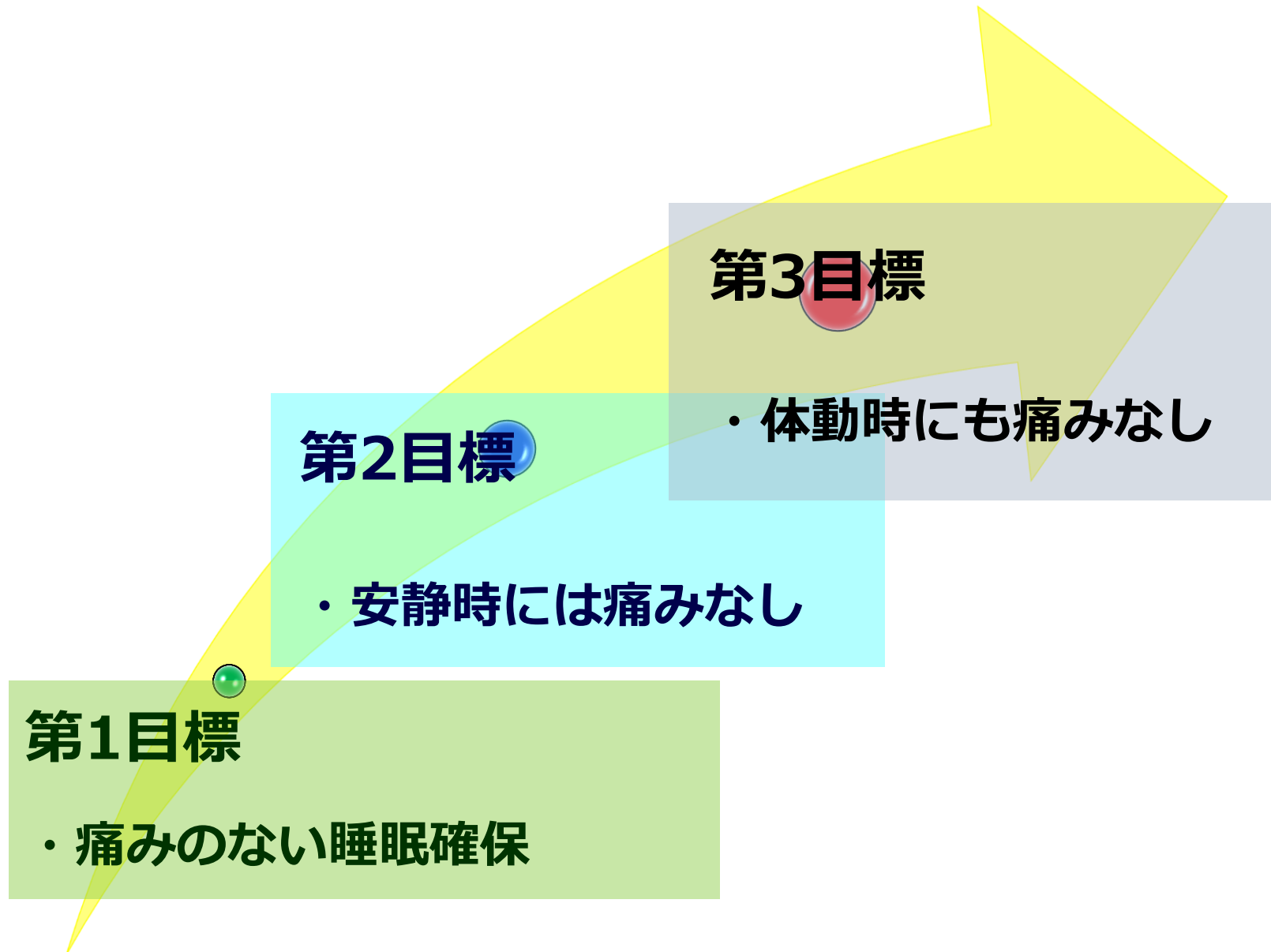
- 経口的に (by mouth)
- 時刻を決めて規則正しく (by the clock)
 - 痛みが出てから鎮痛薬を投与する頓用方式だけでは痛みが消失した状態を維持できない
- ~~除痛ラダーにそって効力の順に (by the ladder)~~
 - ~~患者の予測される生命予後の長短にかかわらず、痛みの程度に応じて躊躇せずに必要な鎮痛薬を選択する~~
- 患者ごとの個別的な量で (for the individual)
- その上で細かい配慮を (with attention to detail)

(参考) WHO三段階除痛ラダー



WHO. *Cancer pain relief* 2nd ed. 1996

WHO 痛みの治療目標



Freedom
from
Pain !

日常生活
社会生活
の回復

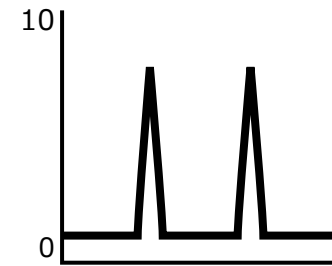
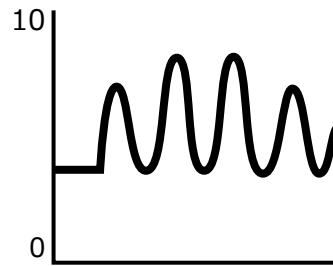
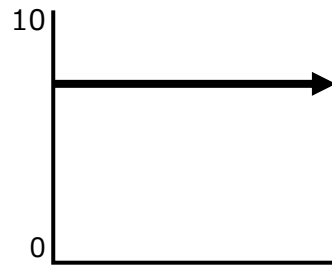
疼痛治療アルゴリズム

手術、化学療法、放射線など
神経ブロック

(1) アセトアミノフェンまたはNSAIDの開始

(2) オピオイドの導入

(3) 残存・増強した痛みの治療



持続的な痛みをとるために
オピオイドを増量する
(持続痛の治療ステップ)

体動時や突然の痛みに対処
するためにレスキューを使う
(突出痛の治療ステップ)

副作用への対策
(特に悪心、便秘、眠気)

痛みをやわらげるケア

非オピオイド鎮痛薬の作用

消化性潰瘍、
腎障害、冠
動脈イベン
トの副作用
に注意

非オピオイド鎮痛薬

非ステロイド
性消炎鎮痛薬
(NSAID)

抗炎症作用

解熱作用

鎮痛作用



アセト
アミノフェン

解熱作用

鎮痛作用

オピオイド

- オピオイド受容体と親和性を有する物質の総称で、モルヒネ様の薬理作用を発揮する
- わが国で利用できるオピオイドのうち、がん疼痛治療薬として推奨されている代表的なもの
 - コデイン、トラマドール
 - モルヒネ、オキシコドン、フェンタニル
 - ヒドロモルフォン、タペンタドール
 - メサペイン

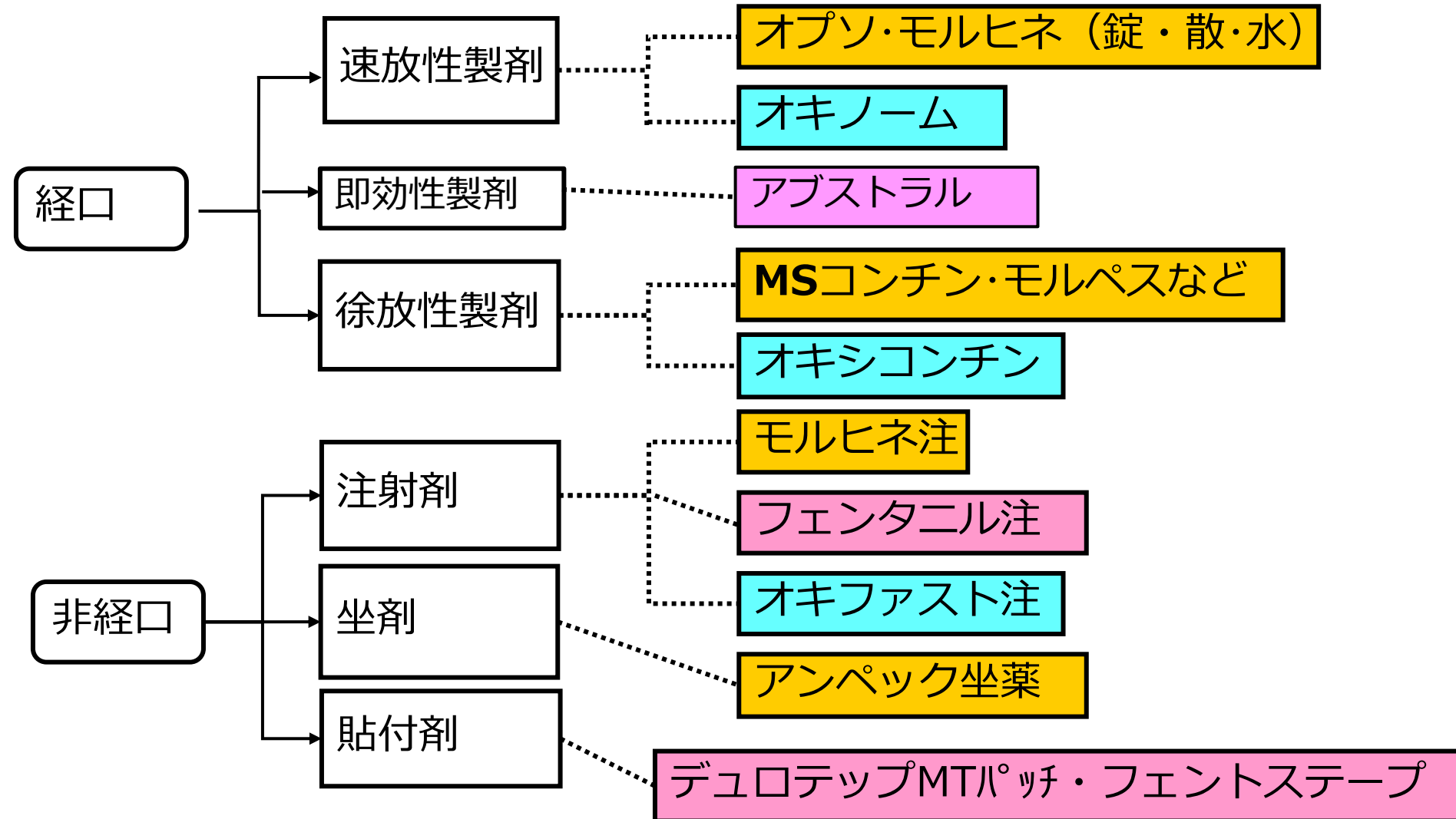
など

オピオイドを始める際に

麻薬と聞くと、本人も家族も不安になるのでしっかり説明

- 痛みのある人に使う分には依存や中毒にはならない
- 寿命を縮めない
- どんな薬でも副作用が出ることがあるが、なるべく出ないように少量から使用していく。もし副作用が出れば副作用に対する薬が使用できる

オピオイドの剤形と製剤



鎮痛補助薬

- ビリビリした痛みやじんじんした痛みなど（神経障害性疼痛）で有効な可能性がある
 - がん患者の約30-40%は神経障害性疼痛を有する
- 鎮痛補助薬の神経障害性疼痛全般に対する有効性：40～60%
 - 副作用（主に眠気）があるので、鎮痛効果と副作用とのバランスをとりながら処方する
- 十分なエビデンスと保険適応がない薬剤が多い

アミトリプチリン、プレガバリン、ガバペンチン、デュロキセチンなど

痛みをやわらげるケア

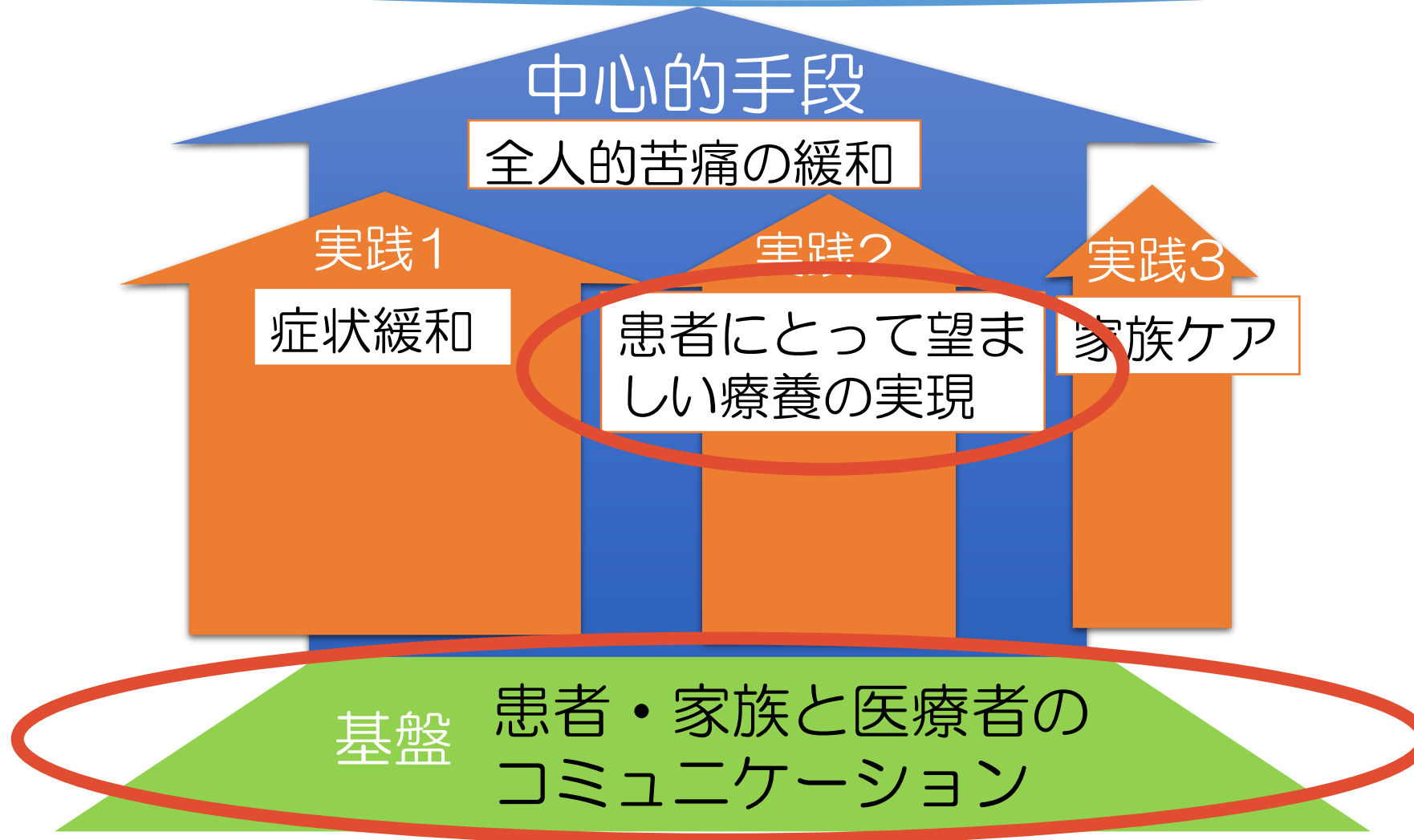
- マッサージ
- 温罨法、冷罨法
- 軽い運動を取り入れる
- 装具や補助具の利用：コルセット、頸椎カラー、歩行器
- 環境調整
- 気晴らし

内容

- 緩和ケアとは
 - 定義と現状
 - 緩和ケアのゴール達成のために
- がんの疫学や経過
- 症状緩和
 - 痛み
- 意思決定支援
 - ACP

緩和ケアのゴール達成のために

緩和ケアのゴール：患者のQOL向上(患者の目標の達成)



医療の意思決定支援

例) 80歳男性。独居で、近隣に住む次女の支援を受けつつ生活をしてきたが、多数の既往疾患があり、徐々にADLの低下がみられていた。ある日、脳梗塞を発症し入院。会話や経口摂取が困難となったため、胃ろうを増設するかを検討している。

医療やケアに関する意思決定は、専門的知識がないと難しい
→専門家（医療者）による意思決定の支援が必要不可欠

どんな情報があれば、
私たちはこの男性の意思決定を支援できるのでしょうか？

以前は医師主導の意思決定

「Aの疾患に対する、Bの状況においては、Cの治療を選択すべし」

例) 脳梗塞後から、誤嚥性肺炎を繰り返す状況なので、胃ろう増設をするべき



父は食べることが好き？
もう一回誤嚥性肺炎を起こしたら死にます！
医師として許せません！
胃ろうを作るべきです！
自分の父親ならそうします！

パターンリズムの時代

どうしたらいいかわからないので、
先生にお任せします。
先生が一番よいと思う形でお願いします、



患者中心の意思決定へ

「患者自身のことは、患者が決める」
→「患者と医療者で協働で決める」

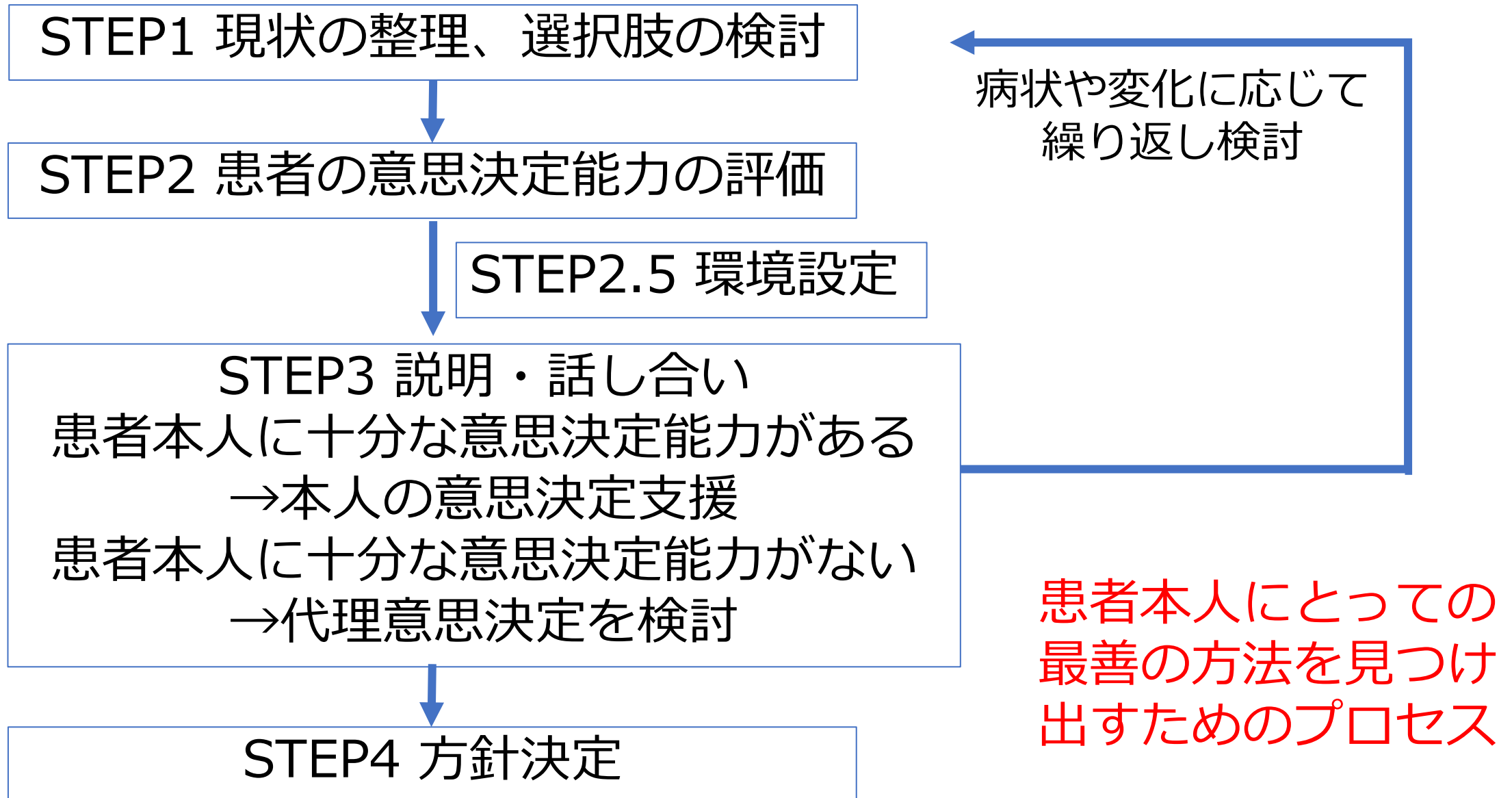
インフォームドコンセント
→シェアードディシジョン
メイキングの時代

- ・医療やケアに関する意思決定は、専門的知識がないと難しい
専門家（医療者）による意思決定の支援が必要不可欠

	パターナリズム	インフォームド・ コンセント	SDM
治療情報の方向	医療者→患者	医療者→患者	医療者↔患者
価値観や生活情報の 方向	医療者→患者	患者→医療者	医療者↔患者
治療方針の検討者	医療者のみ	患者（家族他）	医療者と患者 （家族他）
最終的な治療方針の 決定者	医療者	患者	医療者と患者

表 治療方針決定の3つのアプローチとその特徴(文献5をもとに作成)

意思決定支援プロセスの概要



意思決定支援のプロセス見直し

例) 80歳男性。独居で、近隣に住む次女の支援を受けつつ生活をしてきたが、多数の既往疾患があり、徐々にADLの低下がみられていた。ある日、脳梗塞を発症し入院。会話や経口摂取が困難となったため、胃ろうを増設するかを検討している。

- ①現状の整理、選択肢の検討：胃ろう増設のメリット・デメリットを再考。他の選択肢についても十分検討する
- ②意思決定能力の評価：会話は困難であるが、YES/NOなど簡単な意思疎通も困難か再確認
- ③説明・話し合い：次女・他の家族の意向とその理由を確認しつつ、患者本人ならどう考えるか、患者本人にとって何が最善かを協議する

アドバンス・ケア・プランニング(ACP)とは

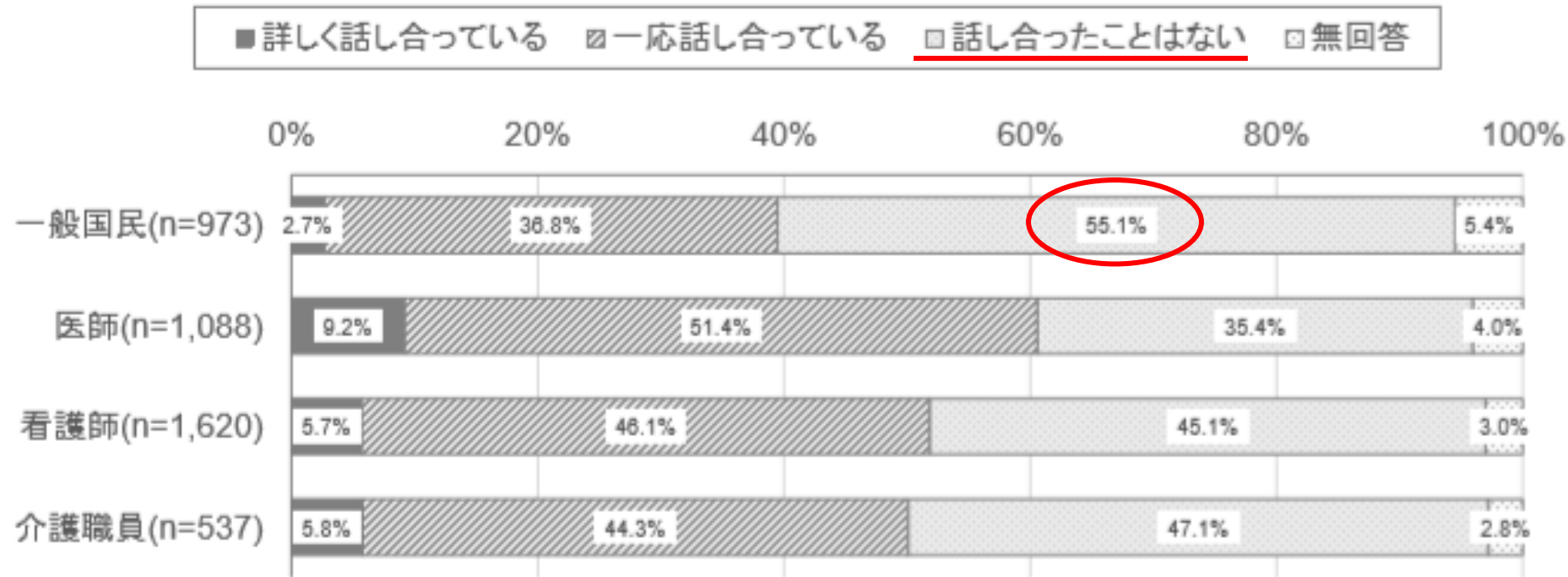
- 重い病気になった際
- 人生の最終段階にさしかかった時に備えて
 - 何を大切にして過ごしたいか
 - どのような医療やケアを受けたいか
 - 自分が判断できない状態の時に、誰に代わって判断してもらうか
- 事前に患者が家族や医療者と繰り返し話し合っておくこと
- 愛称：人生会議(厚生労働省)



なぜACPが必要なのか

「人生の最終段階における医療について、家族と話し合ったことはありますか？」

図1-1-2 人生の最終段階における医療について家族等や医療介護関係者との話し合いについて



終末期では約70%の患者で意思決定が不可能

Silveira MJ, et al. NEJM2011

→それなのに、

もしものときの患者の意向が、家族も医療者もわからない

ACPのはじまり

20世紀の後半より、米国で本人が望まない治療が引き延ばされる。自己決定権が尊重されていないのでは。多額の医療費を賄いきれない。と、議論がはじまり、事前指示(AD)が広がった

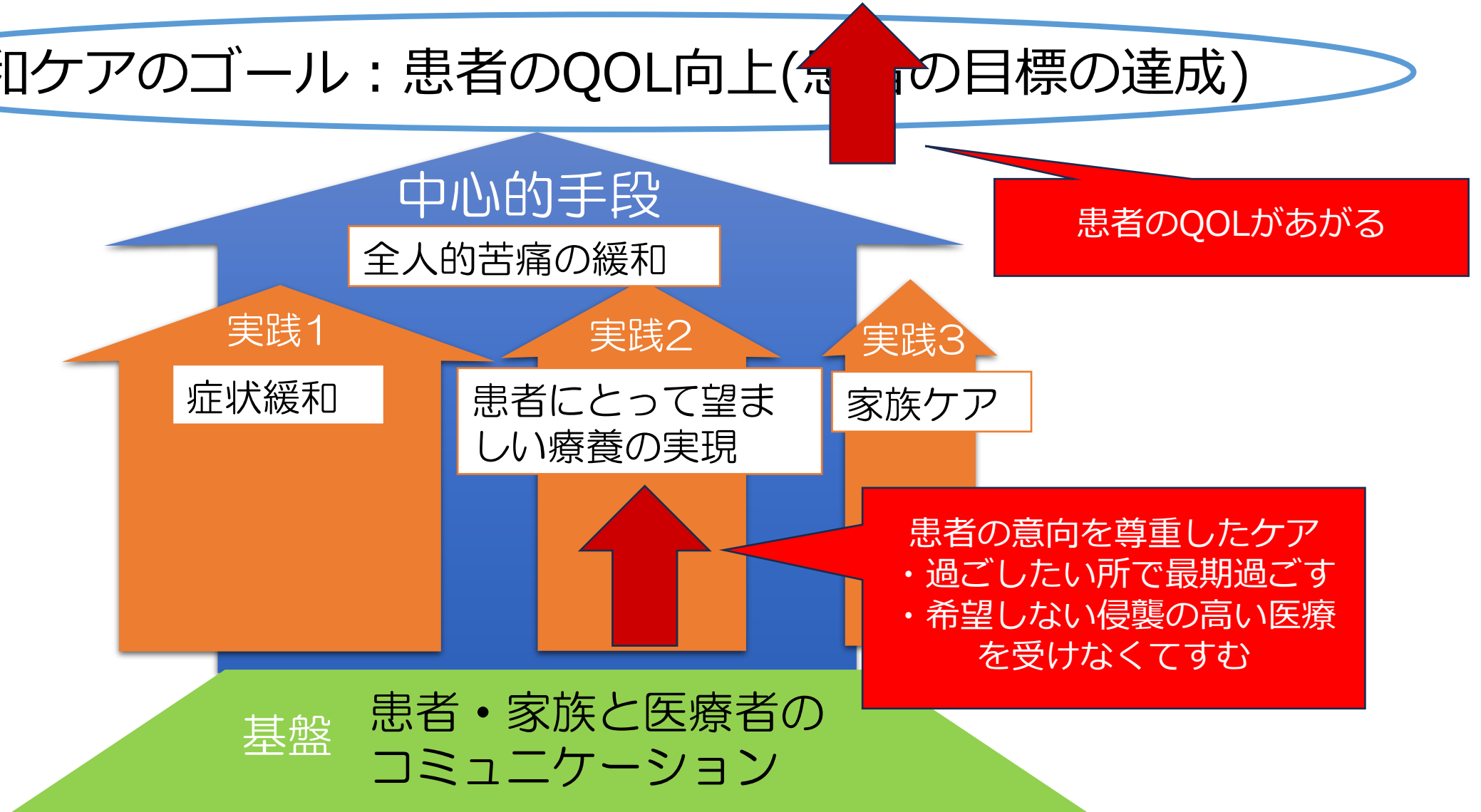


あらかじめ行ってほしい医療処置をADに記載しても、QOL、医療内容、医療費などに効果は認めず・・・

事前指示を残しておくだけでは効果がない。どうしてその選択をしたのか患者の考えや価値観がわかる、プロセスが大事。患者が自分で意思決定できるうちに、もしもの時に備えて今後の意向を患者・家族・医療者で話し合っておこう！
と、ACPがはじまった

ACPへの期待

緩和ケアのゴール：患者のQOL向上(緩和ケアの目標の達成)



ACPは実際どのように役立つのか

- ACP介入によって、中等度から重度の不安および抑うつ症状を示す患者の割合が有意に減少し、終末期ケアに関する希望のコミュニケーションと記録を増加させ、専門的緩和ケアをより頻繁に利用した

Rachelle Bernacki, et al. JAMA Intern Med 2019
Stephanie B Johnson, et al. Br J Cancer .2018
Ida J Korfage, et al. PLoS Med 2020



しかし…

- ACPの目標であった、患者さんの意向を尊重したケアの実現、QOLの改善には結びつかなかった

ACPを行うこと自体が目的となっている・・・
患者が何に困っていて、
何のためにACPを行うのかを今一度考えるべき

ACPが合う人、合わない人

- ・本邦では予後を知りたい患者が半数、明確に聞きたくないのは30%。意思決定を他者に委ねる意向も多い。

Takayuki O, et al.JJCO 2018

- ・根治不能を理解していない進行がん患者は本邦で少なくない

Onishi T, et al. Jpn J clin Oncol 2018

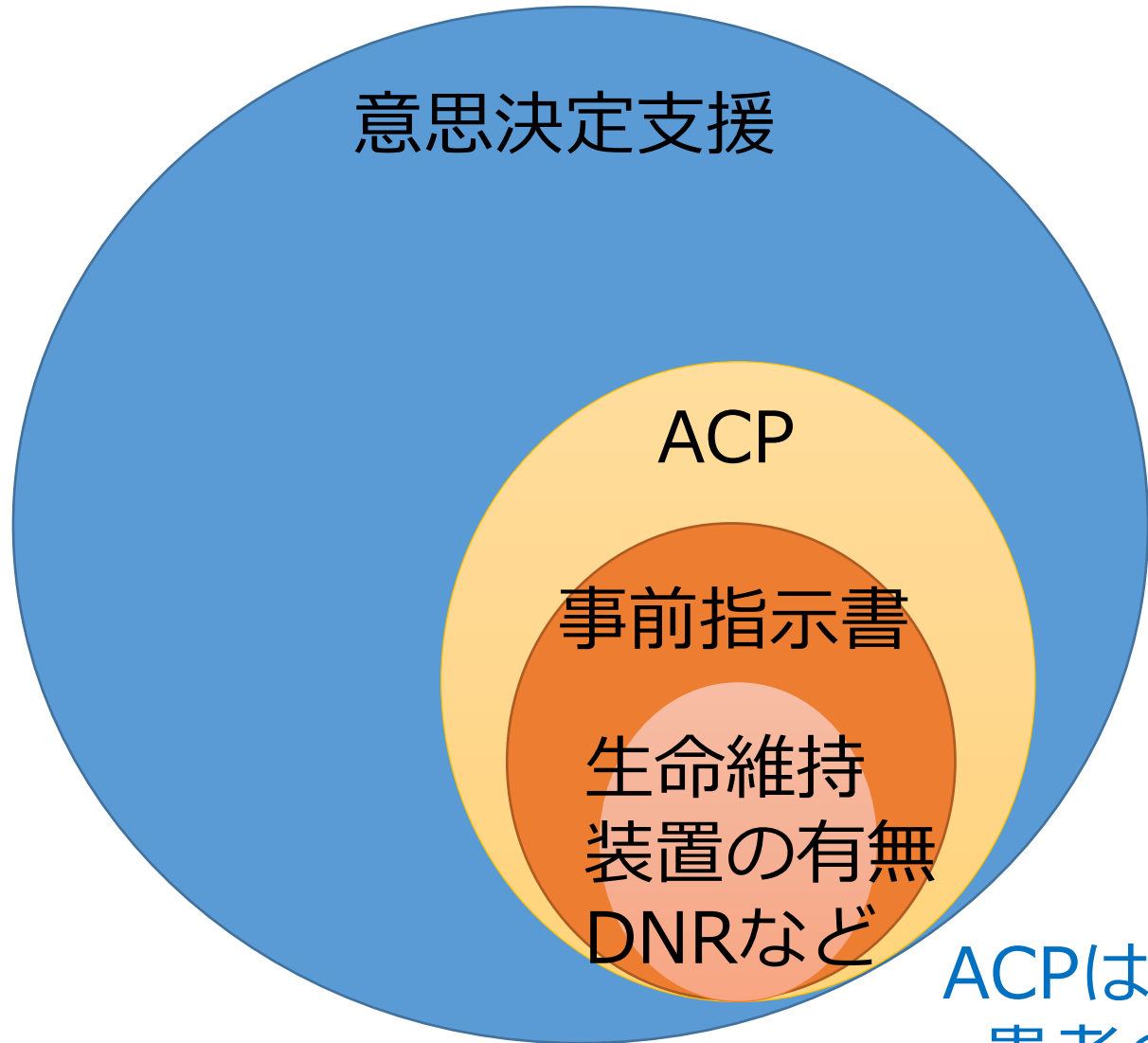
- ・現状を「否認」している人も多い

総病精医 2000

心の準備ができていない人にACPを行うと、侵襲が大きい。

まずは患者の病気・予後への理解を確認し、
話し合う準備ができているか確認していくことが大切

ACPは意思決定支援のごく一部



・ **ACP** : 「もし病気が進行して意識不明になった際は、治療はどうする？」

・ **事前指示書(AD)** : 将来判断能力を失った際に自らに行われる医療行為に対する意向を前もって示すこと

・ **DNR** : 急変時または末期状態で心停止・呼吸停止の場合に、蘇生処置をしないこと

ACPはDNRをとるために行うものではない！
患者の意向を最大限に尊重するために行う

コミュニケーションは医療の基盤

- 医学生の一番の特典は、ローテーションでさまざまな医師のコミュニケーションの場面に立ち会えること
- 特に患者・家族への病状説明は、医師の個性が出る
- これは良いなと思ったコミュニケーションを盗む
 - わかりやすい言い回し、説明の流れなど
 - 必要な情報を伝えているか、患者に伝わっているか
 - 相槌を打ったり頷きなど、非言語的なコミュニケーションも

コミュニケーションで1番大切なことは、患者の病気だけではなく、病気を抱えた目の前のその人に関心をもつこと

まとめ、緩和ケアとは

- 対象はがん患者だけではない
- 早期からの緩和ケアを。診断時から終末期、患者本人が亡くなった後も
- 基本的緩和ケアはすべての医療者が提供できる、すべきもの
- 痛みだけでなく、全人的苦痛などの様々な苦痛緩和や患者の意思決定支援を行う

緩和ケアとは、病気を抱えた人が、その人らしく生きるためにどうすればいいかということに焦点をあてた医療です。

緩和ケアに関する若手支援

- ・ **医学生若手医師のための緩和ケア夏季セミナー**

緩和医療のキャリアパスとロールモデルを示すために緩和医療学会が主催

2009年から毎年開催（2013年からは、1泊2日形式）

COVID-19の影響で近年はwebだったが今年は対面に

- ・ **メーリングリスト**

P-CREG（ぴー・くれっぐ）：Palliative Care Research & Education Group

卒後 20 年目までの医療職および医学生が参加し、
情報交換・相談の場 400名程度